



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA
KOMITE PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI**

**TRIWULAN III
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**LAPORAN KINERJA KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum/Latar belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Disisi lain, rumah sakit menjadi mata rantai transmisi penyakit. Penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs) merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Dalam forum *Asian Pasific Economic Committee* (APEC) atau *Global Health Security Agenda* (GHSA) penyakit infeksi terkait pelayanan kesehatan telah menjadi agenda yang dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa HAIs yang ditimbulkan berdampak secara langsung sebagai beban ekonomi negara.

Secara prinsip, kejadian HAIs sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi merupakan upaya untuk memastikan perlindungan kepada setiap orang terhadap kemungkinan tertular infeksi dari sumber masyarakat umum dan disaat menerima pelayanan kesehatan pada berbagai fasilitas kesehatan.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, perawatan pasien tidak hanya dilayani di rumah sakit saja tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, bahkan di rumah (*home care*).

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

1.3. Maksud dan Tujuan

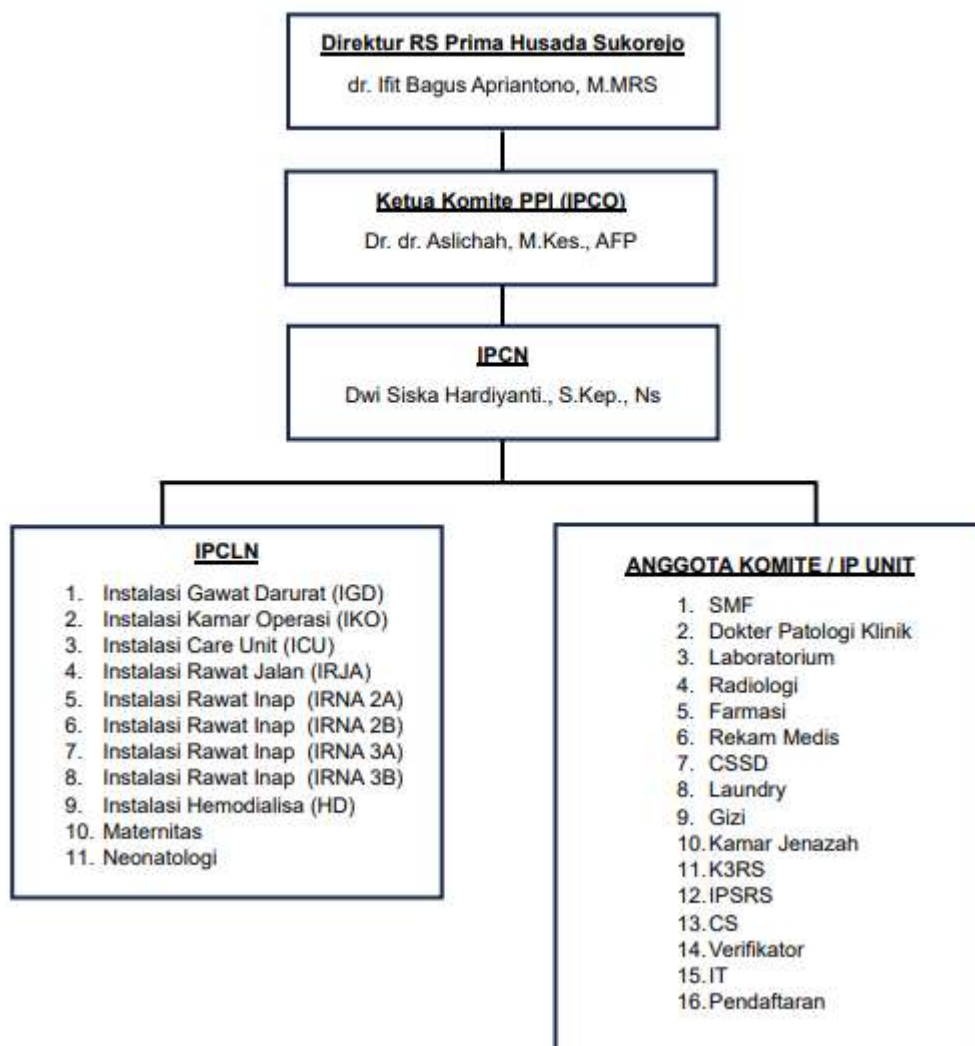
Sebagai panduan untuk pencapaian visi dan misi RS Prima Husada Sukorejo dalam mencapai tujuan organisasi yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional melalui penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, sehingga setiap individu dapat bekerja secara sistematis dan terstruktur.

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
Menjadikan rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan Masyarakat
- 2.2 Misi
1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, cepat, tepat, dan akurat.
 2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
 3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
- 2.3 Motto
“Clean Hands, Save Lives”
- 2.4 7 Nilai Budi Utama
1. Jujur
 2. Tanggung jawab
 3. Dipercaya
 4. Visioner
 5. Kerjasama
 6. Adil
 7. Peduli
- 2.5 SOTK

Gambar 1. SOTK Komite PPI 2025

SOTK KOMITE PPI



BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :

3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Tabel 3..1.1 Ketenagaan

Jabatan	Analisis Beban Kerja	Jumlah SDM												Kebutuhan	Ket.
		Bulan Ke-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
IPCO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	Peremenkes No 27 tahun 2017 1 IPCN = 100 TT
IPCD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1	
IPCN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1-2	

- 3.1.2 Orientasi

Tabel 3.1.2. Pelaksanaan Orientasi PPI RSPH Pasuruan Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Peserta	Pelaksanaan	Hasil Evaluasi orientasi
1.	Januari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Januari 2025		
2.	Februari	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Februari 2025		
3.	Maret	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Maret 2025		
4.	April	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan April 2025		
5.	Mei	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Mei 2025		
6.	Juni	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Juni 2025		
7.	Juli	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Juli 2025		
8.	Agustus	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan Agustus 2025		
9.	September	Tidak ada orientasi staff baru pada bulan September 2025		
Total				

3.1.3 Evaluasi Kinerja Staf

Tabel 3.1.4.1 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Surveilans

UNIT	SURVEILANS												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	100	100	100	85	85	100	100				97
IGD	80	100	100	85	85	85	85	85	85				88
IKO	60	50	0	50	50	0	0	80	60				39
IRJA	40	80	100	100	100	85	85	0	0				66
IRNA 2A	100	100	100	100	100	85	85	100	100				97
IRNA 2B	80	100	80	100	100	85	85	100	100				92
IRNA 3A	100	100	80	100	100	85	85	100	100				94
IRNA 3B	80	100	80	100	100	85	85	100	100				92
MATER	100	100	80	100	100	85	85	100	100				94
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100	85	85	100	100				97
GIZI & DAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FARMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RM & PDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RADIOLOGI	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



Tabel 3.1.4.2 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Bulanan

UNIT	LAPORAN BULANAN												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
IGD	80	80	80	80	60	80	80	80	80				78
IKO	60	50	80	50	50	0	0	80	80				50
IRJA	40	80	80	80	80	80	80	0	0				58
IRNA 2A	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
IRNA 2B	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
IRNA 3A	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
IRNA 3B	80	65	80	80	80	80	80	80	80				78
MATER	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
NEONATOLOGI	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
GIZI & DAPUR	80	80	80	80	80	80	80	80	80				80
FARMASI	60	80	60	60	60	80	80	80	80				76
LAB	80	80	80	80	80	0	0	0	0				42
RM & PDF	60	70	60	60	60	50	50	0	0				46
RADIOLOGI	60	70	60	60	60	50	50	0	0				46
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



Tabel 3.1.4.3 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Edukasi

UNIT	LAPORAN EDUKASI												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
IGD	100	100	100	0	100	100	0	100	100				78
IKO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
IRJA	0	50	100	0	100	0	0	0	0				28
IRNA 2A	50	50	100	100	100	100	100	100	100				89
IRNA 2B	50	100	100	100	100	100	100	100	100				94
IRNA 3A	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
IRNA 3B	50	100	100	100	100	100	100	100	100				94
MATER	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
NEONATOLOGI	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
GIZI & DAPUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FARMASI	0	0	0	0	0	0	100	0	0				11
LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RM & PDF	50	50	0	100	100	100	100	0	100				67
RADIOLOGI	0	0	50	50	0	0	0	0	0				11
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



Tabel 3.1.4.4 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit HH

UNIT	LAPORAN HH												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	100	80	80	70	80	80	100	100				88
IGD	100	100	100	60	100	70	80	100	100				90
IKO	80	70	0	0	50	0	0	80	80				40
IRJA	60	80	60	100	100	70	80	0	0				61
IRNA 2A	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100
IRNA 2B	100	100	80	80	100	100	100	100	100				96
IRNA 3A	100	100	80	80	80	100	100	100	100				93
IRNA 3B	100	40	80	80	100	100	100	100	100				89
MATER	100	100	80	100	100	100	100	100	100				98
NEONATOLOGI	100	100	80	100	100	100	100	100	100				98
GIZI & DAPUR	100	100	80	100	100	100	100	100	100				98
FARMASI	60	100	0	100	100	100	100	100	100				84
LAB	80	100	80	100	0	0	80	100	100				71
RM & PDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RADIOLOGI	60	80	0	0	50	50	0	0	0				27
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0



Tabel 3.1.4.5 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit APD

UNIT	LAPORAN AUDIT APD												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Rerata
ICU	100	80	100	100	0	100	100	100	100				87
IGD	80	80	100	100	100	100	100	100	100				96
IKO	60	60	0	0	50	0	0	80	80				37
IRJA	0	0	80	100	100	100	100	0	0				53
IRNA 2A	80	80	80	100	100	100	100	100	100				93
IRNA 2B	80	80	80	100	100	100	100	100	100				93
IRNA 3A	100	80	80	100	100	100	100	100	100				96
IRNA 3B	80	60	80	100	100	100	100	100	100				91
MATER	100	100	80	100	100	100	100	100	100				98
NEONATOLOGI	100	100	80	100	100	100	100	100	100				98
GIZI & DAPUR	80	80	80	100	100	100	100	100	100				93
FARMASI	60	100	0	100	100	0	0	80	80				58
LAB	80	100	80	100	100	100	100	100	100				84
RM & PDF	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RADIOLOGI	60	80	0	0	0	0	0	0	0				16
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Tabel 3.1.4.6 Evaluasi Kinerja Staf Berdasarkan Pelaporan Audit Program

[illegible]



Tabel 3.1.4.7 Hasil Penilaian PIC PPI Unit Bulan September 2025

UNIT	SURVEILANS	LAPBUL	EDUKASI	AUDIT HH	AUDIT APD	AUDIT PROGRAM	NILAI
ICU	97	80	100	88	87	0	75
IGD	88	78	78	90	96	0	71
IKO	39	50	0	40	37	0	28
IRJA	66	58	28	61	53	0	44
IRNA 2A	97	80	89	100	93	0	76
IRNA 2B	92	80	94	96	93	0	76
IRNA 3A	94	80	100	93	96	0	77
IRNA 3B	92	78	94	89	91	0	74
MATER	94	80	100	98	98	0	78
NEONATOLOGI	97	80	100	98	98	0	79
GIZI & DAPUR	0	80	0	98	93	0	45
FARMASI	0	76	11	84	58	0	38
LAB	0	42	0	71	84	0	33
RM & PDF	0	46	67	0	0	0	19
RADIOLOGI	0	46	11	27	16	0	16
CSSD & LAUNDRY	0	0	0	0	0	0	0



Tabel 3.1.4.8 Analisa dan Tindak Lanjut Penilaian Kinerja PIC PPI Unit 2025

Analisa	Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi penilaian kinerja staf IPCLN dan PIC PPI bulan September tahun 2025 dengan penugasan sebagai berikut, - Pelaporan surveilans - Pelaporan dan penginputan laporan <i>by link</i> - Pemberian edukasi kelompok dan individu dengan sasaran pasien, pengunjung serta staf unit - Pelaporan audit HH - Pelaporan audit APD - Pelaporan audit program Dapat diketahui bahwa pelaporan belum berjalan secara maksimal, dan masih ditemukan beberapa unit yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan secara <i>real time</i>. Adapaun unit dengan rerata skoring tertinggi dan menjadi PIC teladan pada bulan September tahun 2025 yakni Neonatologi dengan skor 79
Rencana Tindak Lanjut	- Berikan penilaian kinerja setiap bulan pada saat melakukan rapat koordinasi komite PPI - Lakukan koordinasi dengan SDM dan berikan reward kepada unit teladan setiap bulannya - Lakukan koordinasi dengan Kabid terkait hasil temuan-temuan setiap bulannya - Lakukan perbaikan dengan IPCN setiap kali melakukan agenda rapat dalam pembahasan temuan-temuan serta kendala pada masing-masing unit - Berikan motivasi kepada semua PIC PPI unit yang baik yang sudah dan belum maksimal dalam melakukan penugasan serta evaluasi secara bersama dengan IPCN - Lakukan koordinasi dengan Kabid serta SDM terkait kepatuhan unit dan staff dalam proses menjadi seorang PIC PPI di unit serta dalam melakukan monitoring PPI di masing-masing unit



3.2 Hasil Pengembangan Pelayanan

Tabel 3.2.1 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan	Bulan	Hasil	Analisa	Rencana Tindak Lanjut
1	Pelatihan	Januari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Januari 2025		
2	Pelatihan	Februari	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan Februari 2025		
3	Pelatihan	Maret (22/03/2025)	1. IDO (Infeksi daerah operasi) bisa di sebabkan oleh faktor endogen (usia, penyakit penyerta, jenis kelamin, pola hidup) dan eksogen (tipe dan lama operasi, keahlian tim bedah, pemilahan operasi, pemasangan impaln, sterilisasi instrumen bedah, kualitas ruang op, kualitas fasilitas/peralatan yang ada di ruang operasi) 2. 4 klasifikasi luka IDO 1) Luka bersih 1-2% 2) Bersih terkontaminasi 6-9% 3) Luka terkontaminasi 13-20% 4) Luka kotor 40% 3. Pemberian profilaksis di lakukan 1 jam sebelum insisi dan sesegera mungkin sebelum dilakukan pembedahan 4. Pemberian profilaksis harus berbeda dengan terapi AB yang digunakan pasien selama proses rawat inap 5. Dikatakan IDO ketika 1) post op hari ke 30-90 yang disertai dengan demam, kemerahan, bengkak, keluar pus	1. Belum adanya SPO pembersihan ruang IKO yang ter-update 2. Tidak patuh dan rutinnya jadwal bongkaran di ruang IKO 3. Tidak patuhnya staff IKO dalam melakukan tatalaksana ruang operasi sesuai dengan prosedur 4. Penerapan bundle IDO di RS belum berjalan sesuai dengan standart 5. Jadwal pemberian profilaksis (antibiotik) di setiap unit masih belum berjalan maksimal 60 menit sebelum jam insisi 6. Masih ditemukan alat di ruang IKO tidak terpusat di CSSD dalam proses pembersihan	1. Pembuatan SPO pembersihan ruang IKO 2. Pembuatan jadwal bongkaran IKO 3. Sosialisasi dan re-edukasi kepatuhan petugas dalam melaksanakan tatalaksana ruang operasi 4. Penerapan bundle IDO oleh unit IKO dan all unit rawat inap serta rawat jalan 5. Edukasi pemberian profilaksis (antibiotik) harus 60 menit sebelum insisi 6. CSSD melakukan pendaataan dan edukasi ulang terkait instrumen yang ada di IKO wajib dilakukan pembersihan dan sterilisasi di CSSD



			2) golden period terjadi pada hari ke 0-30 hari 6. Dampak IDO 1) memperpanjang masa rawat, sering re-admisi, kebutuhan ICU 2) mortalitas meningkat 3) disabilitas permanen 4) prosedur bedah tambahan 5) kontribusi pada peningkatan resistensi antibiotik 7. Teknik penerapan IDO 1) Pre operatif : mandi dengan clorhexidin sehari sebelum op dan hari H ketika proses pembedahan, pencukuran menggunakan cleaper (dilakukan di RS supaya terkontrol oleh petugas tekniknya), pemberian antibiotik kurang dari 120 menit 2) Intra operatif : pemberian O2, pemantauan suhu tubuh, pemantauan gula darah 8. Bongkaran/pembersihan IKO 1) pembersihan harian (dilakukan selama prosedur op telah selesai semua) 2) bongkaran 1 minggu sekali (dilakukan secara rutin dan terjadwal) 3) bongkaran 1 bulan sekali 4) pembersihan pasca renovasi 9. Pembersihan lingkungan		
--	--	--	--	--	--



			1) terdapat SPO tersendiri dalam pembersihan ruang khusus (iko) 2) melakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin (6 bulan sekali) 10. kualitas ruang operasi 1) pintu otomatis 2) tempat cuci tangan menggunakan sensor 11. alur instalasi ruang bedah 1) zona luar : koridor masuk, area transfer, nurse station, area dokumentasi, preoperasi, area ganti baju 2) zona bersih : koridor bersih, ruang simpan alat steril, ruang anastesi dan RR, area istirahat 3) zona retriksi : scrub sinks, ruang operasi 12. persiapan alat/instrumen 1) alat "non kritis" 2) alat "semi kritis" 3) alat "kritis" 13. prinsip rawat luka pasien post op 1) assesmen komprehensif luka dan pasien 2) pengendalian infeksi 3) pemilihan dressing yang tepat 4) manajemen nyeri 5) pendidikan pasien dan keluarga 14. tata kelola kamar operasi		
--	--	--	--	--	--



			1) penjadwalan operasi : mengatur (mengatur kamar operasi, operator dna tim operasi, durasi op) 2) persiapan pasien 3) koordinasi tim medis 4) pengurangan waktu tunggu 5) alur pasien yang efisien 15. manajemen linen 1) penanganan linen di kamar op harus sesuai 2) pemisahan linen kotor terkontaminasi darah atau cairan tubuh dengan linen kotor tidak terkontaminasi 3) tidak menempatkan linen di lantai 4) semua linen infeksius dimasukkan ke dalam kantong dengan kode infeksius 5) linen yang terkontaminas cairan tubuh dibersihkan sebelum proses selanjutnya 16. manajemen limbah 1) pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya 2) tempatkan limbah sesuai dengan jenisnya 17. sterilisasi dan perawatan peralatan medis 1) sterilisasi alat bedah 2) desinfeksi permukaan 3) penyimpanan yang tepat 4) pemeliharaan yang rutin		
--	--	--	--	--	--



			18. semua peralatan/instrumen bedah wajib di lakukan sterilisasi di CSSD 19. ruang/gedung kamar operasi : boleh sampai dengan lt. 4 dengan memperhatikan struktur dan arah cahaya dari banguna		
4	Pelatihan	April 2025	Tidak ada staff yang melakukan pelatihan internal atau eksternal di bulan April 2025		
5	Pelatihan	Mei 2025	Total Undangan: 466 peserta Total Kehadiran: 322 peserta Total Tidak Hadir: 144 peserta Persentase Kehadiran: 69,10% Persentase Ketidakhadiran: 30,90% Nilai Rata-Rata Peserta: Pre-Test : 88 / 100 Post-Test : 95 / 100 Rata-rata tanya jawab saat praktik : 74,06 / 80 Hasil Pelatihan PPI All Staff 1. Cuci Tangan a. Staff tidak melakukan pelepasan aksesoris, namun Ketika sudah dilakukan edukasi dan sosialisasi staff paham b. Langkah cuci tangan terbolak balik antara Langkah ke 3 dan ke 4 c. Langkah cuci tangan “mengunci” menjadi kendala dari staff pelatihan	1. Kehadiran Peserta: Persentase kehadiran sebesar 69,10% menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup baik, namun masih ada sekitar 30,90% peserta yang tidak hadir. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut terkait alasan ketidakhadiran (jadwal, sosialisasi, dukungan pimpinan, dsb). 2. Peningkatan Nilai - Terdapat peningkatan nilai dari 88 (pre-test) menjadi 95 (post-test), yang menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap materi PPI meningkat setelah pelatihan. - Rata-rata post-test mendekati sempurna, mengindikasikan bahwa materi disampaikan dengan	1. Evaluasi Ketidakhadiran: - Lakukan survei singkat atau konfirmasi ke unit terkait untuk mengetahui penyebab utama ketidakhadiran 146 peserta. - Koordinasikan dengan pimpinan unit untuk mendukung keikutsertaan dalam pelatihan selanjutnya. 2. Pelatihan Ulang: - Jadwalkan sesi pelatihan susulan atau pelatihan ulang bagi peserta yang tidak hadir untuk memastikan seluruh SDM memahami PPI dasar. 3. Monitoring dan Implementasi - Lakukan audit kepatuhan terhadap PPI pasca pelatihan untuk menilai



			d. Langkah cuci tangan ke dua “punggung tangan” banyak staff yang tidak menempelkan telapak tangan ke punggung tangan e. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal 5 momen cuci tangan f. Masih ada beberapa staff yang tidak hafal terkait waktu cuci tangan g. Masih belum pahamnya staff terkait tujuan dan manfaat cuci tangan 2. Spillkit a. Staff belum paham penggunaan spillkit b. Staff tidak paham isi dan kegunaan spillkit c. Staf masih bingung terkait Langkah-langkah penggunaan spill kit dan masih terbolak balik Langkah, a) Penggunaan APD (urutan penggunaan dan pelepasan APD) b) Penyiapan kresek c) Pemberian pasir/serbuk kayu dengan jarak 10-20 cm d) Kapan pemberian klorin pada saat ada tumpahan DUH pasien e) Penggunaan klorin tidak dipakai pada saat terjadi tumpahan B3	efektif dan dapat diterima dengan baik oleh peserta. - Rata-rata tanya jawab langsung ketika melakukan praktikum sebesar 74,06 yang menunjukkan peserta 3. Kurang patuhnya staff unit dalam menerapkan 6 langkah cuci tangan dan	penerapan di unit kerja masing-masing - Berikan feedback berkala ke unit terkait praktik PPI (misalnya: kebersihan tangan, penggunaan APD, etika batuk, dll) 4. Peningkatan Berkelanjutan: - Sertakan materi PPI dasar dalam orientasi karyawan baru. - Rancang materi PPI lanjutan untuk meningkatkan kedalaman pemahaman dan kompetensi staf Rencana Tindak Lanjut terkait Materi praktek dalam PPI, 1. Cuci Tangan a. Melakukan pelatihan ulang berbasis demonstrasi langsung dan praktik. b. Menyediakan poster visual 6 langkah cuci tangan dan 5 momen WHO di setiap unit. c. Evaluasi dan simulasi periodik.
--	--	--	--	--	--



			3. Penggunaan APD a. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan penggunaan APD b. Staff belum paham dan masih terbolak balik dalam urutan pelepasan APD c. Kebutuhan APD di unit sudah terpenuhi, hanya unit IRNA 2A (R. Isolasi yang belum memenuhi kebutuhan APD masker N95 yang diperuntukkan untuk masuk keruang isolasi) 4. Pemilahan sampah a. Staff bingung dalam melakukan pembuangan cairan DUH pasien dan pembuangan botol yang terkena DUH pasien infus kemana b. Staff bingung dalam melakukan pengikatan sampah infeksius/non infeksius/ botol infus 5. Penanganan Linen a. Staff masih bingung Ketika ditemukan DUH pasien di linen (harus di buang dulu DUH pasien) lalu di masukkan kedalam kresek infeksius 6. Proses Dekontaminasi alat a. Staff masih bingung untuk proses awal perendaman / dekontaminasi dari unit (alat		d. Kampanye mini tentang manfaat cuci tangan melalui media internal (TV, flyer, poster). e. Penugasan role model (champion hygiene) di tiap unit. 2. Spillkit a. Melakukan pelatihan ulang menggunakan alat spillkit secara langsung. b. Membuat SOP visual/spillkit flowchart yang ditempatkan di area risiko tinggi. c. Simulasi rutin tumpahan DUH dan B3. d. Pemberian kartu ringkasan urutan spillkit untuk staf. 3. Penggunaan APD a. Pelatihan ulang dengan simulasi step-by-step penggunaan dan pelepasan APD. b. Penambahan kebutuhan APD ke IRNA 2A. c. Menempelkan panduan poster urutan APD di setiap ruang tindakan.
--	--	--	--	--	---



			direndam terlebih dahulu menggunakan cairan deterjen kemudian di turunkan ke CSSD) b. Beberapa alat setelah di pakai tidak di turunkan dikarenakan lupa, dan hanya diletakkan di dalam kresek kuning, bukan di box instrument kotor		d. Pembuatan video internal panduan penggunaan APD. 4. Pemilahan Sampah a. Penyusunan ulang SOP pemilahan limbah dengan contoh visual. b. Sosialisasi dan simulasi secara langsung. c. Penempatan label warna yang jelas pada setiap kantong dan tempat sampah. 5. Penanganan Linen a. Sosialisasi prosedur penanganan linen terkontaminasi DUH secara rinci. b. Pelatihan simulasi dan role play. c. Penempatan instruksi singkat di area laundry dan tempat pengumpulan linen. 6. Dekontaminasi Alat a. Edukasi ulang urutan dekontaminasi alat: dari perendaman hingga
--	--	--	---	--	--



					pengiriman yang dilakukan oleh statff CSSF b. Audit harian terhadap kepatuhan pengiriman alat kotor ke CSSD.
6	Pelatihan	Agustus 2025	1. Pemasangan CVC tidak boleh dilakukan di vena femoral. 2. Penggunaan APD harus lengkap sesuai urutan dari bawah ke atas (sepatu, gown, masker, nurse cap, google, sarung tangan steril, drapping). 3. Bundle CLABSI wajib diterapkan di unit khusus, mulai sebelum hingga setelah penggunaan CVC. 4. Pasien yang diduga CLABSI harus dilakukan kultur darah (perbandingan kanan dan kiri) sesuai regulasi dan SPO. 5. Pasien dengan CVC dari luar harus dipertahankan maksimal 1x24 jam kemudian diganti sesuai prosedur. 6. Pasien hemodialisa dengan CVC wajib dilakukan kultur darah bila ada indikasi infeksi.	1. Risiko tinggi CLABSI masih dapat terjadi bila pemasangan dilakukan di vena femoral karena lokasi ini rawan kolonisasi bakteri. 2. Kepatuhan penggunaan APD sering menjadi kendala di lapangan sehingga perlu pengawasan ketat. 3. Bundle CLABSI belum konsisten diterapkan di semua unit, sehingga perlu standarisasi. 4. Kultur darah penting untuk diagnosis pasti CLABSI, namun masih ada keterlambatan atau ketidaksesuaian prosedur. 5. CVC dari luar sering dipertahankan melebihi 24 jam karena kurangnya pengawasan, meningkatkan risiko infeksi. 6. Pasien HD dengan CVC berisiko tinggi infeksi, sehingga kultur darah wajib untuk deteksi dini.	1. CVC dipasang di vena femoral RTL : Revisi SPO dan sosialisasi pemasangan CVC (hindari vena femoral) Penanggung jawab : Komite medik dan komite PPI Waktu : 2 minggu 2. Kepatuhan penggunaan APD RTL : Monitoring dan evaluasi kepatuhan APD< breafing rutin sebelum tindakan Penanggung jawab : IPCN, kepala ruang Waktu : Rutin 3. Bundle CLABSI belum konsisten RTL : implementasi bundle CLABSI di seluruh unit khusus Penanggungjawanan : Tim PPI dan Kepala Ruang Icu/HD Waktu : 1 bulan 4. Kultur darah tidak sesuai dengan SPO RTL : penyusunan dan sosialisasi SPO kultur darah, pelatihan teknis pengambilan



					Penanggungjawaban : lab mikrobiologi dan komite medik Waktu : 1 bulan 5. CVC dari luar >24 jam RTL : pengawasan dan pencatatan waktu pemasangan CVC dari luar Penanggungjawab : Perawat ruangan, DPJP Waktu : Rutin 6. Pasien HD dengan CVC berisiko infeksi RTL : wajib kultur darah pasien HD dengan CVC bila indikasi infeksi Penanggungjawab : Dokter Sp.PD dan perawat HD Waktu : Rutin

3.3 Kinerja Produktifitas Komite PPI

3.3.1 Kewaspadaan Isolasi

a. Kewaspadaan Standart

Tabel 3.3.1.1 Kewaspadaa Standart

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	PENYUNTIKAN YANG AMAN	80,00%	89,30%	86,50%	82,22%	81,64%	95,37%	89,54%	80,16%	80,56%	86,11%				85,71%	86,01%	88,85%	82,28%	
2	PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI VAKSIN	80,00%	100,00%	94,44%	95,39%	92,88%	100,00%	100,00%	93,45%	100,00%	98,68%				97,20%	96,61%	97,63%	97,38%	
3	PENGELOLAAN STERILISASI DAN BMHP	80,00%	97,24%	92,72%	90,27%	93,33%	95,80%	96,28%	91,60%	95,59%	97,65%				94,50%	93,41%	95,14%	94,95%	
4	PENGELOLAAN LINEN/LAUNDRY	80,00%	96,43%	88,31%	89,01%	87,07%	90,48%	94,44%	89,88%	87,50%	91,83%				90,55%	91,25%	90,66%	89,74%	
5	PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS RS	80,00%	100,00%	94,05%	94,41%	96,88%	96,58%	98,77%	96,30%	94,91%	97,61%				96,61%	96,15%	97,41%	96,27%	
6	PENANGANAN SPESIMEN DARAH DAN CAIRAN TUBUH LAIN	80,00%	90,48%	100%	92,50%	96,88%	98,75%	98,75%	100,00%	100,00%	92,66%				96,67%	94,33%	98,13%	97,55%	
7	PENANGANAN TUMPAHAN DARAH DAN CAIRAN TUBUH	80,00%	91,09%	85,96%	84,43%	94,05%	89,90%	95,22%	92,21%	95,00%	91,07%				90,99%	87,16%	93,06%	92,76%	
8	PENANGANAN DAN PENGIRIMAN SAMPAH DI RUANGAN	80,00%	93,33%	95,36%	84,63%	90%	93,75%	91,41%	90,52%	93,33%	92,96%				91,70%	91,11%	91,72%	92,27%	
9	PEMBUANGAN BENDA TAJAM	80,00%	72,77%	72,08%	87,73%	92,71	94,64%	92,36%	90,03%	87,50%	87,99%				86,42%	77,53%	93,24%	88,51%	
10	PELAYANAN MAKANAN	80,00%	75,00%	90,83%	85,00%	91,64%	94,17%	94,05%	88,33%	89,17%	87,50%				88,41%	83,61%	93,29%	88,33%	



11	LINGKUNGAN RUMAH SAKIT	80,00%	33,70%	63,31%	70,94%	95,17%	85,71%	86,24%	86,72%	89,10%	90,75%				77,85%	56,65%	88,05%	88,86%	
12	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN APD DI UNIT	80,00%	96,45%	91,42%	94,21%	95,17%	99,38%	92,70%	100,00%	100,00%	91,29%				95,62%	94,03%	95,75%	97,10%	
13	KAMAR JENAZAH	80,00%	87,50%	91,43%	95,24%	100%	100,00%	100,00%	91,67%	100,00%	90,00%				95,09%	91,39%	100,00%	93,89%	
14	FASILITAS KEBERSIHAN TANGAN	80,00%	96,59%	95,83%	93,43%	91,89%	94,97%	93,33%	86,66%	93,71%	90,17%				92,95%	90,93%	90,39%	90,18%	
15	DEKONTAMINASI MOBIL AMBULAN	80,00%	95,00%	90%	87,78%	96,67%	91,16%	83,33%	86,67%	83,33%	83,33%				88,59%	92,21%	88,75%	84,44%	
16	ETIKA BATUK	80,00%	98,61%	99,16%	78,85%	90,28%	86,67%	89,29%	81,48%	91,67%	90,91%				89,66%	60,35%	71,81%	88,02%	
17	KELENGKAPAN PENGISIAN DATA PPI	80,00%	47,08%	58,53%	75,43%	67,58%	74,49%	73,37%	85,41%	90,00%	67,86%				71,08%	90,93%	90,39%	81,09%	

b. Kewaspadaan Isolasi

Tabel 3.1.1.2 Kewaspadaan Isolasi

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	PENEMPATAN PASIEN INFEKSI AIRBONE DALAM WAKTU SINGKAT	80,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-
2	PENEMPATAN PASIEN IMMUNOCOMPROMISED	80,00%	62,50%	58,33%	95,00%	85%	58,33%	83,33%	72,73%	100,00%	91,66%				78,54%	71,94%	75,55%	88,13%
3	PENEMPATAN DAN TRANSFER INFEKSI PASIEN AIRBONE	80,00%	63,49%	73,15%	78,42%	68,25%	68,52%	87,50%	77,45%	80,95%	69,23%				74,11%	71,69%	74,76%	75,88%

3.3.2 Audit Bundle HAI's PPI

Tabel 3.3.2.1 Tabel Audit Bundle HAI's PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%	0,00%	0,00%	0%	
2	CLABSI		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
3	VAP		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0%				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
4	PLEBITIS & PLABSI		1,39%	1,14%	2,41%	2,08%	3,49%	3,46%	2,27%	2,88%	3%				2,42%	1,65%	3,01%	2,93%	
5	IDO		0%	0,89%	1,19%	0%	0%	0%	0,00%	0,55%	0%				0,36%	0,69%	0,09%	0,18%	
6	DEKUBITUS		0%	0%	2	0	0	0	1	0	0				0,375	0,66	0	0,33	

NO	INDIKATOR PENILAIAN	KET	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III	RATA-RATA TW IV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	CAUTI (ISK)	HARI PEMAKAIAN	62	142	174	195	52	82	209	205	218				146	126	110	211	
2	CLABSI (CVC)		11	10	13	4	4	7	35	12	20				13	11	5	22	
3	VAP		41	13	34	14	30	28	40	25	39				29	29	24	35	
4	IDO	JUMLAH PASIEN OP DALAM PERIODE TERTENTU (BULAN)																	
	SC		81	63	92	92	82	77	96	86	90				84	79	84	91	
	ORIF		25	40	42	42	31	33	36	30	33				35	36	35	33	
	APENDICTOMI		12	9	3	8	10	15	18	23	20				13	8	11	20	
	HERNIOTOMI		25	22	11	16	28	22	21	17	18				20	19	22	19	
	KATARAK		31	33	29	30	30	30	30	30	31				30	31	30	30	
	CABG		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
	TU MAMAE		20	20	15	22	25	30	17	11	16				20	18	26	15	
	LAPAROTOMI		26	37	22	13	19	30	32	31	25				26	28	21	29	



3.3.3 Mutu PPI

Tabel 3.3.3.1 Mutu PPI

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW I	RATA-RATA TW II	RATA-RATA TW III
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	60%	62%	82,75%	81,80%	82,39%	96,86%	90,00%	90,00%	90%	82,80%				83,17%	75,38%	86,52%	90,00%
2	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI's (Health care Associated Infection) di RS	75%	3,55%	1,07%	3,87%	6,33%	75,85%	69,66%	75,19%	76%	76,00%				43,06%	2,83%	50,61%	75,60%
3	Kepatuhan kebersihan tangan	>85%	74,75%	77,24%	78,95%	83,80%	81,66%	88,59%	76,39%	75,98%	74,81%				79,13%	76,98%	84,68%	76,19%
4	Kepatuhan APD	100%	89,64%	89,87%	84,84%	97,92%	98,07%	93,80%	92,01%	84%	83,55%				90,39%	88,12%	96,60%	87,93%
5	Angka infeksi daerah operasi	<1.5%	0%	0,89%	1,19%	0%	0,00%	0,00%	0%	0,55%	0,00%				0,29%	0,69%	0,00%	0,28%
6	Kepatuhan penempatan pasien infeksius (kewaspadaan transmisi)	100%	52,46%	87,50%	97,14%	95%	100,00%	88,00%	90,00%	100%	86,96%				88,56%	79,03%	94,33%	95,00%
7	Kejadian pelaporan tertusuk jarum <48 jam	0 kejadian	0	0	0	0	1	0,00%	0,00%	0	0,00%				0,11	0	0,33	0
8	Kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap	100%	55,24%	63,69%	60%	79,50%	72,75%	86,09%	90,00%	88,85%	90,00%				76,24%	59,64%	79,45%	89,43%
9	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standar (2/3 wadah)	100%	87,10%	83%	90,91%	97,31%	84,42%	90,91%	94,11%	94,11%	90,71%				90,21%	85,05%	90,88%	94,11%
10	Kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN	100%	47,13%	58,53%	59,26	56,67%	75,85%	78,54%	66,67%	69,58%	78,63%				65,65%	54,97%	70,35%	68,13%



11	Kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh	100%	1,24%	1,37%	9,52%	11,90%	7,14%	16,67%	21,43%	100%	100,00%				29,92%	4,04%	11,90%	60,72%
12	Edukasi kelompok terkait PPI	100%	27,28%	47,22%	55,88%	44,44%	44,12%	50,00%	47,06%	47,06%	88,89%				50,83%	43,46%	48,04%	47,06%

BAB IV

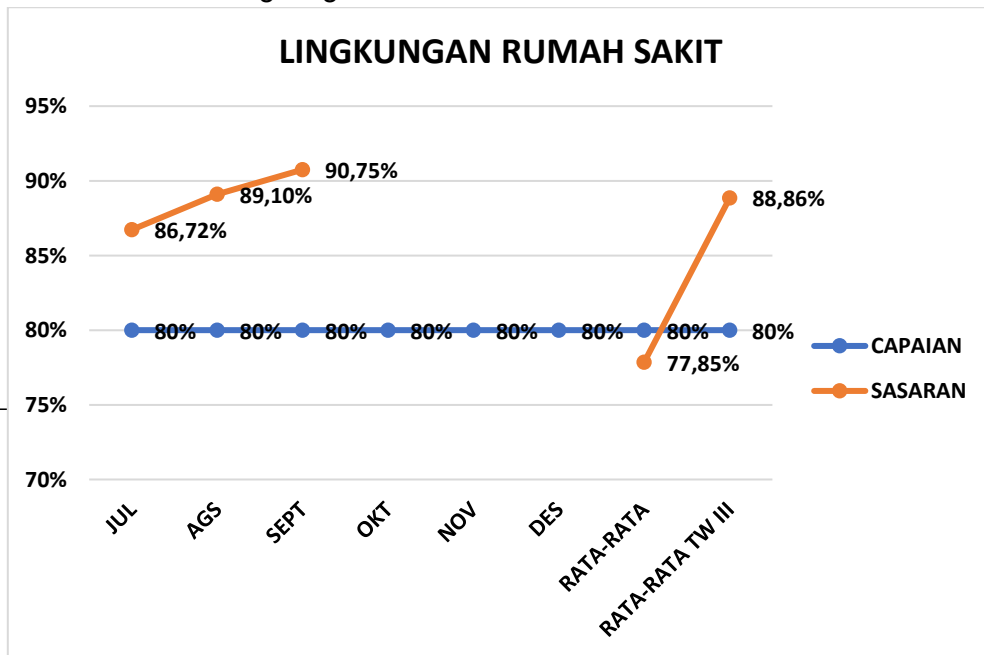
PEMBAHASAN KINERJA PRODUKTIFITAS KOMITE PPI

- 4.1 Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 4.1.1 Monitoring Kewaspadaan Isolasi

a. Kewaspadaan Standart

a) Lingkungan Rumah Sakit

Gambar 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.1 diketahui bahwa rerata lingkungan rumah sakit di bulan September 2025 sebesar 90,75% dengan rerata triwulan sebesar 88,86% dan sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.1 Lingkungan Rumah Sakit

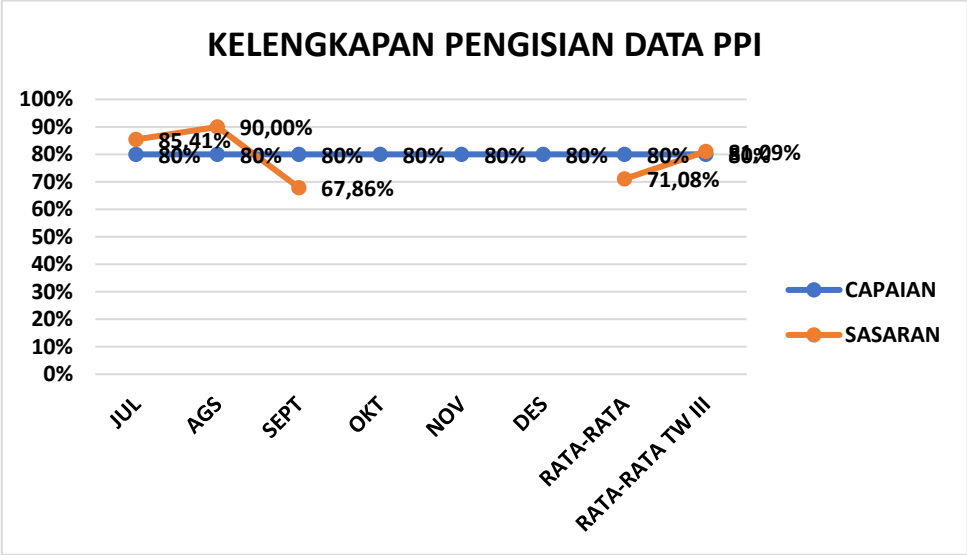
PROBLEM	Data menunjukkan fluktuasi tingkat kepatuhan dengan rerata 90,75%
STEP	Monitoring berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan di area rumah sakit.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap kebersihan lingkungan rumah sakit hingga minimal 80% sesuai target pada semua bulan berjalan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya kepatuhan staff dalam menjaga kebersihan area kerja b. Pengawasan atau audit tidak berjalan setiap hari c. Tidak tersosialisasi dan tidak diterapkannya SOP terkait kebersihan lingkungan RS d. Kurangnya motivasi atau reward bagi petugas kebersihan yang berdinis

	4. Tindakan - Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan (baik secara mingguan dan memberikan umpan balik) - Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Menyediakan checklist kebersihan harian
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	- Nilai kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 90,75% dengan rerata triwulan sebesar 88,86% dan sudah mencapai sasaran 80%. - Monitoring capaian kepatuhan setiap minggu - Lakukan perbandingan hasil kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan dengan bulan sebelumnya - Evaluasi area dengan peningkatan dan penurunan - Survei kepuasan staff dan petugas terhadap sistem baru
ACTION	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan dengan baik sesuai dengan standart - Beri feedback pada hasil temuan - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit dengan SOP dan audit sebagai standar rutin - Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi sesuai dengan SOP dan audit sebagai standar rutin

Tabel 4.1.1.2 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

b) Kelengkapan Penginputan Data Surveilans
Gambar 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.4 diketahui bahwa rerata kelengkapan penginputan data surveilans di bulan September 2025 sebesar 67,86% dengan rerata triwulan sebesar 81,09% dan sudah mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.4 Kelengkapan Penginputan Data Surveilans

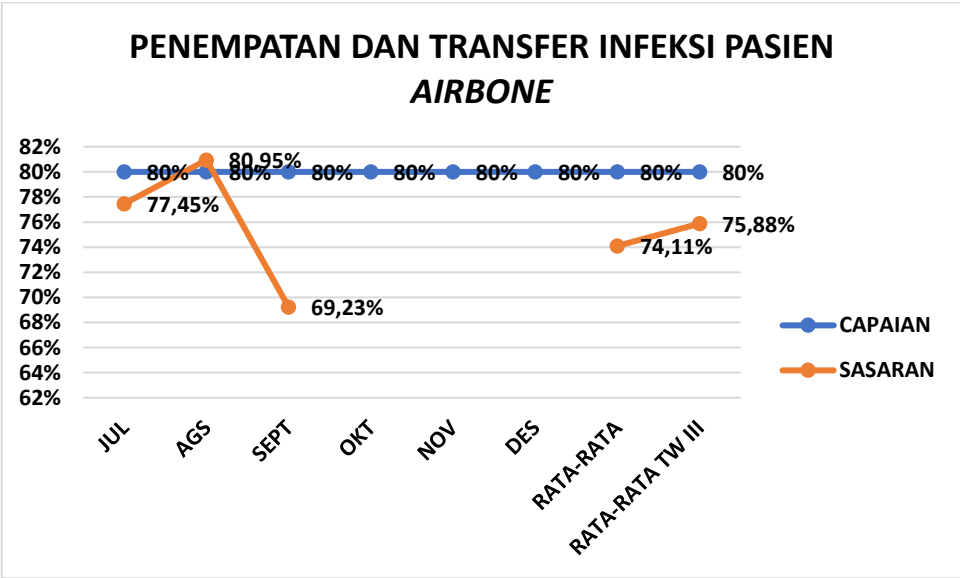
PROBLEM	Persentase kelengkapan penginputan data surveilans bulan September tahun 2025 sebesar 67,86% dengan rerata triwulan 81,09% dan sudah mencapai target 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring 11 kewaspadaan transmisi serta kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kelengkapan pengisian data pencegahan dan pegendaian infeksi hingga mencapai target minimal 80% setiap bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara <i>real time</i> dan <i>ontime</i> sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Analisa penyebab potensial a. Kurangnya pemahaman staff tetang pentingnya pencatatan data PPI b. Format pencatatan yang banyak yang harus di isi oleh PJ unit c. Tidak adanya system monitoring pengisian data secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring 11 kewaspadaan standart serta

	kewaspadaan isolasi c. Memberikan pelatihan kepada seluruh staff terkait pengisian data d. Monitoring mingguan oleh tim PPI terhadap pengisian data
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans belum mencapai target 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di bulan September 2025 sebesar 67,86% dengan rerata triwulan sebesar 81,09% dan sudah memenuhi standart 80% 2. Lakukan survei terhadap staff untuk mengetahui hambatan dalam pengisian 3. Bandingkan tingkat kelengkapan data bulan berjalan dengan bulan sebelumnya
ACTION	1. Lakukan evaluasi pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi dengan melibatkan Karu dan Kabid terkait. 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faham 4. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 5. Perbaiki format atau system pengsiisan berdasarkan masukan staff 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

Tabel 4.1.1.5 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

- b. Kewaspadaan Transmisi
- a) Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*
- Gambar 4.1.1.5 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.5 diketahui bahwa rerata penempatan dan transfer infeksi pasien *airbone* di bulan September 2025 sebesar 69,23% dengan rerata triwulan yang belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.6 Penempatan dan Transfer Infeksi Pasien *Airbone*

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan dan transfer infkesi pasien <i>airbone</i> untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan terhadap penempatan dan transfer pasien dengan infeksi airborne agar mencapai target minimal 80% 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Analisa penyebab potensial ; a. Kurangnya pemahaman staff mengenai prosedur airborne precaution b. Tidak semua ruang perawatan dilengkapi system isolasi airborne c. Koordinasi antar unit dalam proses transfer masih lemahn 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> di unit secara

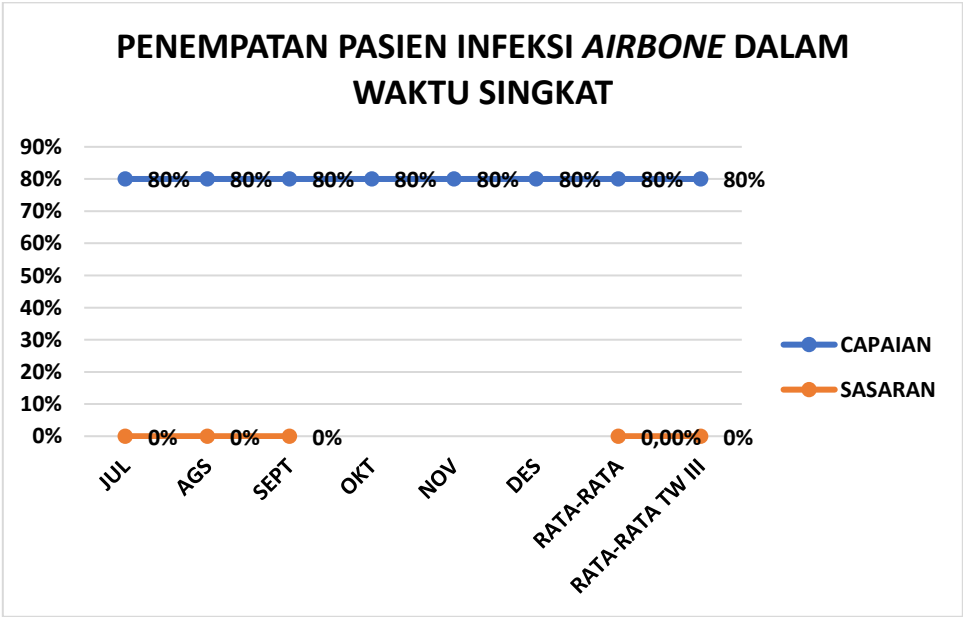
	berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> sesuai dengan SOP dan standart yang berlaku c. Koordinasi dengan IPCLN melalui grub komunikasi aktif di unit untuk meningkatkan kepatuhan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> belum mencapai 80%
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 69,23% dengan rerata capaian triwulan sebesar 75,88% dan belum mencapai target 80%, 2. Monitoring kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dilakukan secara mingguan 3. Evaluasi dilakukan terhadap proses transfer yang terjadi setiap bulan 4. Lakukan audit terhadap dokumentasi penempatan pasien 5. Evaluasi terhadap kepatuhan petugas dalam menggunakan APD 6. Monitoring kepatuhan edukasi staff terhadap keluarga/pengunjung pasien terhadap a. Kepatuhan penggunaan APD b. Etika Batuk c. Kebersihan tangan
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i>. 2. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 3. Aktivkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS untuk penertiban pengunjung di area ruang Isolasi, 4. Perkuat system pemantauan dan laporan internal 5. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan, 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan dan transfer infeksi pasien <i>airbone</i> dengan tepat

Tabel 4.1.1.7 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

	pada Triwulan berikutnya												
2	Refresh SPO yang tersedia terkait a.Kebersihan Tangan b.Etika Batuk c. Penggunaan APD												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin penempatan pasien di ruang Isolasi baik pasien dari IGD yang ditransfer ke												

- b) Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat
- Gambar 4.1.1.7 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat



Interpretasi : Pada gambar 4.1.1.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi *airbone* dalam waktu singkat di bulan September 2025 sebesar 0% dan belum mencapai standart 80%.

Tabel 4.1.1.8 Penempatan Pasien Infeksi *Airbone* dalam Waktu Singkat

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam



	melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i>
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat di unit secara berkesinambungan, b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat, c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat belum mencapai 80%.
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 0%, 2. Ditemukan data sebesar 0% dikarenakan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat tidak adapat terukur secara <i>real time</i>
ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IGD untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan audit secara berkesinambungan Bersama IPCLN IGD 4. Beri <i>feedback</i> pada hasil temuan. 5. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat.

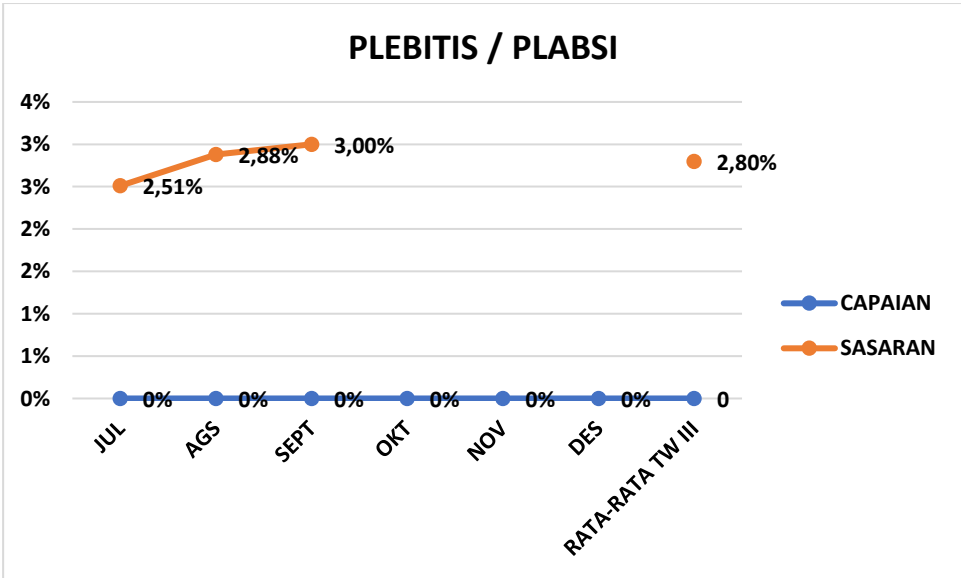
Tabel 4.1.1.9 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Koordinasi dengan Ka. IGD untuk melakukan re-sosialisasi penempatan pasien Isolasi												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin penempatan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat												

4.1.2 Audit *Bundle* HAI's PPI

a. *Bundle Phlebitis*

Gambar 4.1.2.1 Phlebitis



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian phlebitis di bulan September 2025 sebesar 3% dan belum mencapai standart 0%.



Tabel 4.1.2.1 Phlebitis

No	Bulan	Unit	Jumlah Phlebitis
1	Januari	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	4
		IRNA 2B	2
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
2	Februari	IRNA 3A	0
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	6
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	1
		ICU	0
3	Maret	IRNA 3A	6
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	6
		IRNA 2B	4
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	0
4	April	IRJA	7
		IRNA 3A	15
		IRNA 3B	3
		IRNA 2A	3
		IRNA 2B	7
		NEONATOLOGI	1
		IRJA	2
5	Mei	IRNA 3A	19
		IRNA 3B	7
		IRNA 2A	7
		IRNA 2B	26
		NEONATOLOGI	0
		MATERNITAS	0
		IRJA	0
6.	Juni	IRNA 3A	9
		IRNA 3B	9
		IRNA 2A	10
		IRNA 2B	17
		MATERNITAS	2
		NEONATOLOGI	2
		ICU	2
7.	Juli	IRNA 3A	11
		IRNA 3B	8
		IRNA 2A	8
		IRNA 2B	15
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	0
8.	Agustus	IRNA 3A	9
		IRNA 3B	6
		IRNA 2A	5
		IRNA 2B	19
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	1
9.	September	IRNA 3A	9



		IRNA 3B	15
		IRNA 2A	13
		IRNA 2B	12
		MATERNITAS	0
		NEONATOLOGI	0
		ICU	1
TOTAL			342

Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui kejadian plebitis terbanyak di unit IRNA 3B sebesar 15 kejadian.

Tabel 4.1.2.2 PDSA Phlebitis

PROBLEM	Persentase kejadian plebitis belum mencapai standart 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian plebitis untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian phlebitis menjadi $\leq 1\%$ dalam 3 bulan . 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian plebitis dan dapat menurunkan kejadian plebitis di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; b. Ketidaksesuaian prosedur pemasangan infus c. Lama pemasangan infus >72 jam d. Kurangnya pencatatan dan monitoring harian e. Minimnya pelatihan atau refreshment untuk tenaga medis 4. Tindakan a. Sosialisasi SOP pemasangan dan perawatan infus b. Audit harian terhadap pemasangan dan perawatan infus c. Pembatasan lama pemasangan infus maksimal 72 jam d. Pelatihan ulang tenaga medis tentang pencegahan phlebitis e. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien infeksi <i>airbone</i> dalam waktu singkat baik antar staf, pasien, keluarga bahkan hingga ke pengunjung.
DO	Angka kejadian plebitis dapat mencapai 0%.
STUDY	1. Data kejadian phlebitis pada bulan September sebesar 3% dengan rerata triwulan 2,80% dan belum mencapai target 0% 2. Evaluasi angka kejadian phlebitis setiap minggu 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP

ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika angka tetap tinggi; b. Evaluasi Kembali penyebab utama c. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan d. Pertimbangkan revisi SOP bila tidak sesuai praktik lapangan
---------------	---

Link	rekap	Plebitis	PPI	2025	:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XjGil_YwmlziDYeUHxce3xvO36M89OgWvYhlgKjDDWE/edit?usp=sharing					

Tabel 4.1.2.3 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

Gambar 4.1.2.1 Bundle IDO

LAPORAN DATA ANALISIS INFEKSI DAERAH OPERASI TAHUN 2025												PT. DISA PRIMA MEDIKA												
No	Bulan/Tanggal Pelaporan	Inisial Pasien	No RM	Unit	Usia	Tgl/Jam MRS	DPJP	Penjamin	Tgl Operasi	Dx Operasi & Tindakan Operasi	Tim Operasi				Kontrol ke	Riwayat Rawat Luka Post Op	Hasil Penunjang Abnormal		Terapi Saat ILO	Assesmen lain	Praduga Penyebab ILO	RTL	Total Kejadian IDO	
											Ast Bd	dr.An	Ast. An	Instrumen			Onloop	Saat Op						Saat IDO
JANUARI																								
Februari																								
1	13/02/2025	NY ZHILA QITRIYAH	113689	POLI OBGYN	27 TH	04/02/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 1	04/02/2025	G1P0A60 UK 40-41 MOG DO SEVERE CUJO DO LETAK ORUQ + ULTAH TALI PUSAT	EDO	HARLI	RIZKI	KIKIS	SILFI	1	Ada rembesan di area balutan, terdapat pusih dan berbau tidak sedap	Hb : 12,2 L : 8.400 T : 198.000	-	VIT C 2X1 ONOWA 1X1	-	Obesitas 68kg ke 93 kg	MENJAGA BALUTAN LUKA AGAR TETAP KERSIH BLA TERJADI REMBESAN MAKA GIGANTI	1
2	28/02/2025	NY KHORO UMAH	081324	29	59 TH	11/02/2025 # 26/02/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 3	11/02/2025 # 28/02/2025	I APPENDICITIS AKUT # ILEUS OBSTRUKTIF	KIKIS EDO	BOBI HERU	ROHMAN AGUNG	EKO ANTOK	DAMANG SILFI	Kontrol poli ke I post MRS pertama tanggal 21/02/2025	Rawat luka terbuka	OP KE 1 Hb: 12,4 L: 8.800 T 243.000 GDS 349	-	Ranitidin 2x1 Ondans 3x1 Santagesik 3x1 Metronidazole 3x1 Meropenem 3x1	Obat KRS Cefiam 2x200 mg Etiavel 2x1 OMZ 2x1 Belafti 1x1	GDA tinggi	RL luka khusus oleh tenaga ahli Diet DM Penggunaan obat-obatan harus di minum secara teratur	2
Maret																								
1	05/03/2025	NUL WIDAYATI	113570	POLI BEDAH	34 TH	27/02/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	27/02/2025	S. APPENDICITIS AKUT	EDO	BOBI	AGUNG	KIKIS	DAMANG	Kontrol I 05/03/2025	-	Hb 14,1 L 11.700 T 343.050 GDS 116	-	Obat post kontrol poli Cefiam 2x100 Bu profil 2x100 OMZ 2x1	Rawat luka bersih menggunakan cutiset Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gut yang dikonsumsi kurang (protein) Konsumsi air putih kurang	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani Banyak melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	3
2	05/03/2025	FARIDA NURDANA	035075	POLI BEDAH	48 TH	24/02/2025	DR. RIFTA	BPJS KLS 3	25/02/2025	S. APPENDICITIS AKUT + S. CHOLELITIASIS	WAFI	HARLI	RIZKI	FENDRA	NKO	Kontrol I 05/03/2025	-	-	-	Obat post kontrol Tympheoricol 4x1 Metronidazole 3x1 Asam Mefenamat 3x1	Rawat luka bersih Setiap luka rembes wajib di ganti	Mobilisasi sedikit Gut yang dikonsumsi kurang (protein) I tarak makan	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	4
3	07/03/2025	RATNA DEWI	080619	POLI BEDAH	42 TH	23/02/2025	DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	24/02/2025	MAMAE ABRERIAN D / EXCSI	WAFI	HERU	ROHMAN	FENDRA	DAMANG	Kontrol I 28/02/2025 Kontrol II 07/03/2025	Keluar cloth pada saat kontrol ke dua	Hb 12,8 L 5.800 T 185.000 Hasil PA : Jinak	keluar gumpalan darah di kesak "area insisi"	Bu profil 2x1 Cefiam 2x100 mg	Luka tidak di jahit, di tampon menggunakan kasa Luka diberikan cutiset, dan ditutup kasa steril	Kurangnya mobilisasi	Rawat luka tap 2 hari sekali, (Luka yang di aft jahitan diben dan di tampon kasa) Evaluasi kembali 14/03/2025	5
4	24/03/2025	LUTFANINGSIH	087805	IRMA 2A	35 TH	23/03/2025	DR. SANTOSO DR. ROSY ZAKI	BPJS KLS 1	12/03/2025	MOMA UTERI	EDO	HARLI	RIZKI	EKO	NKO	Kontrol I 20/03/2025	Keluar pusih diantara jahitan pasien ketika di bawah ke IGD	Hb 10,1 L 8.200 T 596.050 GDS 70 PPT 13,0 APPT 30,5	Hb 10,3 L 15.100 T 540.000	Ceftriaxon 2x1 Metronidazol 3x1 Santagesik 3x1 Ranitidin 2x1 Obat TB	Rawat luka menggunakan cutiset tap pagi atau bila rembes	Gut pasien kurang	Rawat luka tap pagi Konsumsi obat TB	6
April																								
Mei																								
Juni																								
1	17/06/2025	SOFIFA	121438	POLI OBGYN	45 TH	02/06/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 3	04/06/2025	TUMOR PERVAGNA	WAFI	HARLI	RIZKI	FENDRA	NKO	Kontrol I 09/06/2025	jahitan basah	Hb : 12,4 L : 12.000 T : 310.000	-	Onowa 1x1 Asmeif 3x1	Rawat luka dan ganti perban setiap rembes	Gut pasien kurang (tidak tinggi protein)	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	7
Juli																								
Agustus																								
1	30/08/2025	MAYA FEBRINA	53216	POLI OBGYN	36 TH	20/08/2025	DR. SANTOSO	BPJS KLS 1	20/08/2025	G2P1A80 UK 34-36 LETSU BSC + USA >36 TH	EDO	HERU	RIZKI	ANTOK	SILFI	Kontrol I 30/08/2025	keluar pusih dan seta-sela jahitan	Hb : 12,4 L : 13.000 T : 278.000	Hb : 11,3 L : 19.500 T : 255.000	Cefadroxil 3x1 Bedistap 3x1 Asmeif 3x1	Rawat luka dan ganti perban setiap rembes	Gut pasien kurang (tidak tinggi protein)	Rawat luka bersih di rumah dengan cairan NS Banyak mengkonsumsi protein hewani melakukan mobilisasi (tidak melakukan aktivitas berat)	8
2																								
September																								
Oktober																								
November																								
Desember																								



Interpretasi : Berdasarkan gambar 4.1.2.3 dapat diketahui jumlah Bundle IDO di bulan Agustus 1 kasus.

Link Rekap analisa IDO 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B0O4PmS-oovztJNlJw_Te2hQkENP-MWt/edit?usp=sharing&oid=112970937896793169786&rtpof=true&sd=true

Tabel 4.1.2.4 PDSA Bundle IDO

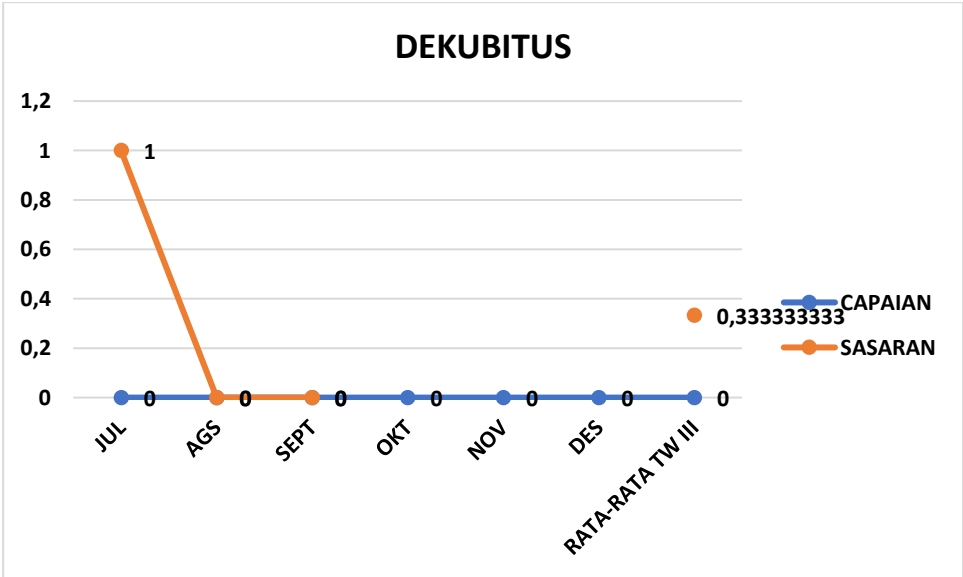
PROBLEM	Persentase kejadian IDO bulan September 2025 sebesar 0% dengan rerata triwulan belum mencapai standar 0%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit IRJA, IGD dan rawat inap mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian IDO untuk mengurangi resiko akibat pemasangan infus dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai standart
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian IDO menjadi <0,2% dalam 3 bulan kedepan. 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian IDO dan dapat menurunkan kejadian IDO di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi;
	a. Kepatuhan aseptis saat operasi belum maksimal b. Sterilisasi alat belum diaudit secara menyeluruh c. Antibiotic profilaksis tidak diberikan tepat waktu d. Monitoring luka pascaoperasi belum optimal 4. Tindakan a. Penegakkan protokol aseptis secara ketat (5 momen kebersihan tangan, sterilisasi alat, dan penggunaan APD yang sesuai) b. Pemberian antibiotic profilaksis 30-60 menit sebelum insisi c. Audit sterilisasi alat operasi d. Monitoring luka operasi dan edukasi pasien post-op
DO	Angka kejadian IDO dapat mencapai 0% dengan menerapkan, 1. Terapkan system cheklist pre-op untuk memastikan pemberian antibiotik dan sterilisasi 2. Lakukan pelatihan ulang tim bedah dan perawat mengenai protocol pencegahan IDO 3. Audit harian pada ruang operasi dan rawat inap pasca-operasi 4. Edukasi psien dan keluarga tentang perawatan luka di rumah
STUDY	1. Data kejadian IDO pada bulan September sebesar 0 kejadian dengan rerata triwulan kejadian 0,33% dan belum mencapai target 0% 2. Tinjau tren angka IDO setiap minggu 3. Lakukan evaluasi melalui audit kepatuhan prosedur dan insiden harian 4. Identifikasi apakah terjadi penurunan kejadian dan kepatuhan meningkat
ACTION	1. Jika angka IDO menurun : terapkan prosedur

	sebagai standar dan teruskan monitoring 2. Jika belum berhasil maka, a. Perbaiki SOP sesuai temuan lapangan b. Tambah frekuensi supervise dan audit c. Evaluasi kinerja individu yang tidak patuh dan lakukan pembinaan
--	---

Tabel 4.1.2.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Re-view ulang pelaporan IDO yang terjadi di unit												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin kejadian IDO												

- c. Dekubitus
- Gambar 4.1.2.2 Kejadian Dekubitus



Interpretasi : Pada gambar 4.1.2.1 diketahui bahwa rerata kejadian Dekubitus di bulan September 2025 sebesar 0 kejadian



Tabel 4.1.2.6 PDSA Bundle Dekubitus

PROBLEM	Kejadian dekubitus pada bulan September sebanyak 0 kejadian, serta kejadian dekubitus dalam triwulan di temukan pada bulan Juli sebanyak 1 kejadian
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit rawat inap dan unit khusus (ICU) mengenai pentingnya kepatuhan pelaporan kejadian dekubitus untuk mengurangi resiko decubitus pada pada pasien tirah baring lama melalui peningkatan kepatuhan terhadap pencegahan luka tekan sesuai dengan standart PPI
PLAN	1. Rencana: Menurunkan angka kejadian dekubitus menjadi 0 kejadian dalam 3 bulan . 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pelaporan kejadian dekubitus dan dapat menurunkan kejadian dekubitus di masing-masing unit. 3. Akar masalah yang diidentifikasi; a. Ketidakpatuhan staff dalam melakukan tindakan keperawatan mika-miki pada pasien tirah baring b. Ketidakpatuhan staff melakukan edukasi terkait penggunaan kasur dekubitus 4. Tindakan a. Melakukan skrining risiko decubitus menggunakan skala Braden pada saat pasien masuk b. Memberikan pelatihan kepada perawat tentang pencegahan luka tekan c. Menyediakan alat bantu seperti Kasur decubitus dan posisi miring berkala (2 jam) d. Edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya mobilisasi dini dan perawatan kulit
DO	Angka kejadian dekubitus dapat mencapai 0 kejadian.
STUDY	1. Data kejadian dekubitus pada bulan September sebesar 0 kejadian dengan rerata belum mencapai target 0 kejadian 2. Peningkatan kepatuhan dokumentasi perubahan posisi pasien dari 40% menjadi 85% 3. Bandingkan data sebelum dan sesudah intervensi 4. Tinjau hasil audit dan identifikasi unit yang masih belum patuh terhadap SOP
ACTION	1. Jika angka menurun : terapkan intervensi sebagai prosedur standart baru 2. Jika masih ditemukan kejadian decubitus maka, a. Evaluasi Kembali penyebab utama b. Tambahkan intervensi, seperti supervise lebih ketat dan intensif terhadap kepatuhan c. Melakukan audit bulanan kepatuhan dokumentasi posisi dan perawatan kulit

	d. Memberikan pelatihan rutin PPI dengan focus pencegahan infeksi dari luka tekan
--	---

Tabel 4.1.2.7Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

4.1.3 Mutu PPI

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

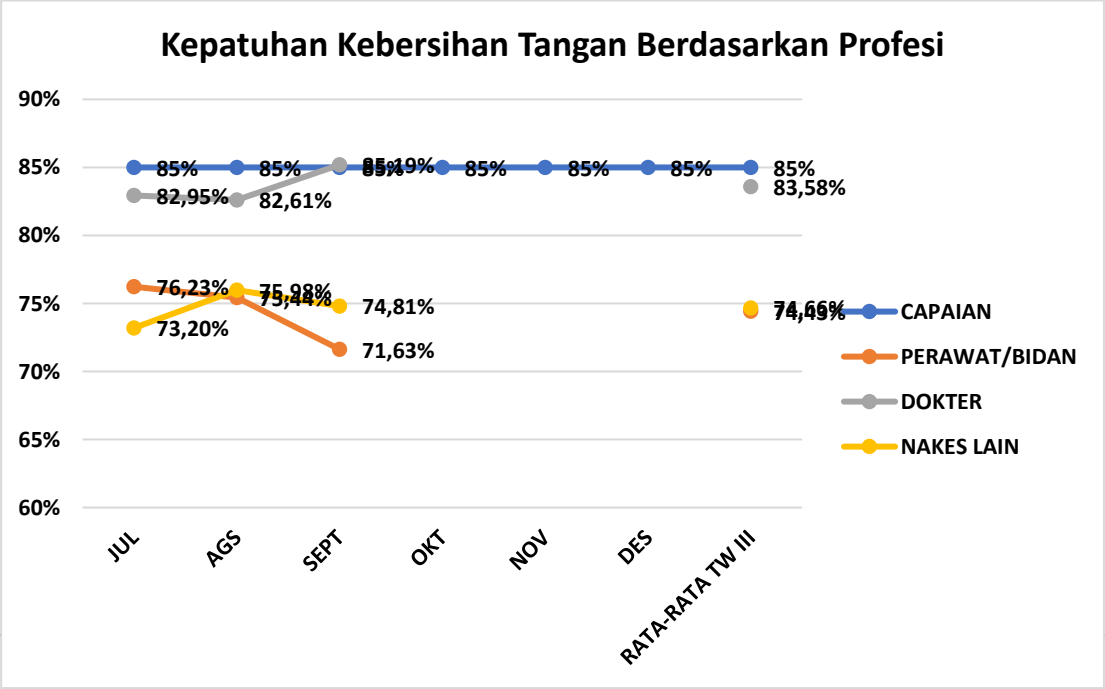
a) Berdasarkan Unit

Tabel 4.1.3.1 Kepatuhan Kebersihan Tangan

NO	INDIKATOR PENILAIAN	STANDART	BULAN												RATA-RATA	RATA-RATA TW III
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	3A	85%	76,36%	80,77%	88,41%	82,46%	85,11%	95,83%	76,47%	69,23%	75,93%				81,17%	73,88%
2	3B	85%	87,50%	44,44%	41,43%	86,96%	85,03%	71,05%	74,29%	69,52%	70,37%				70,07%	71,39%
3	2A	85%	100%	50,00%	71,34%	77,91%	69,03%	86,67%	52,50%	69,68%	73,11%				72,25%	65,10%
4	2B	85%	100%	100%	78%	77,91%	73,12%	80,85%	58,93%	69,60%	71,21%				78,85%	66,58%
5	2D	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
6	MAT	85%	80%	71,79%	68%	86,67%	92,47%	94,00%	85,19%	73,91%	80,00%				81,36%	79,70%
7	NEO	85%	72,73%	89,02%	96%	88,79%	93,55%	96,81%	87,10%	91,30%	84,31%				88,81%	87,57%
8	ICU	85%	100%	100%	75%	75%	100,00%	65,00%	81,82%	90,91%	83,33%				85,67%	85,35%
9	IKO	85%	100%	44,44%	0%	75%	46,15%	0,00%	0,00%	92,00%	71,43%				47,67%	54,48%
10	IGD	85%	58,57%	77,78%	84%	82,35%	80,49%	94,59%	87,80%	71,43%	75,00%				79,09%	78,08%
11	IRJA	85%	100%	78,23%	83%	84,40%	86,96%	79,07%	71,83%	0,00%	0,00%				64,81%	23,94%
12	CS	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
13	As. Center	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
14	Farmasi	85%	100%	72,41%	0%	88,10%	87,36%	100,00%	94,67%	100,00%	76,13%				79,85%	90,27%
15	Laboratorium	85%	100%	100%	94%	88,51%	0,00%	0,00%	0,00%	74,19%	70,00%				58,49%	48,06%
16	Radiologi	85%	0%	100%	0%	77,78%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	75,00%				50,31%	25,00%
17	Gizi dan Dapur	85%	62,50%	78,26%	97%	84,72%	86,65%	88,41%	77,33%	79,49%	74,36%				80,99%	77,06%
18	RM / PDF	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
19	CSSD	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%
20	LAUNDRY	85%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%

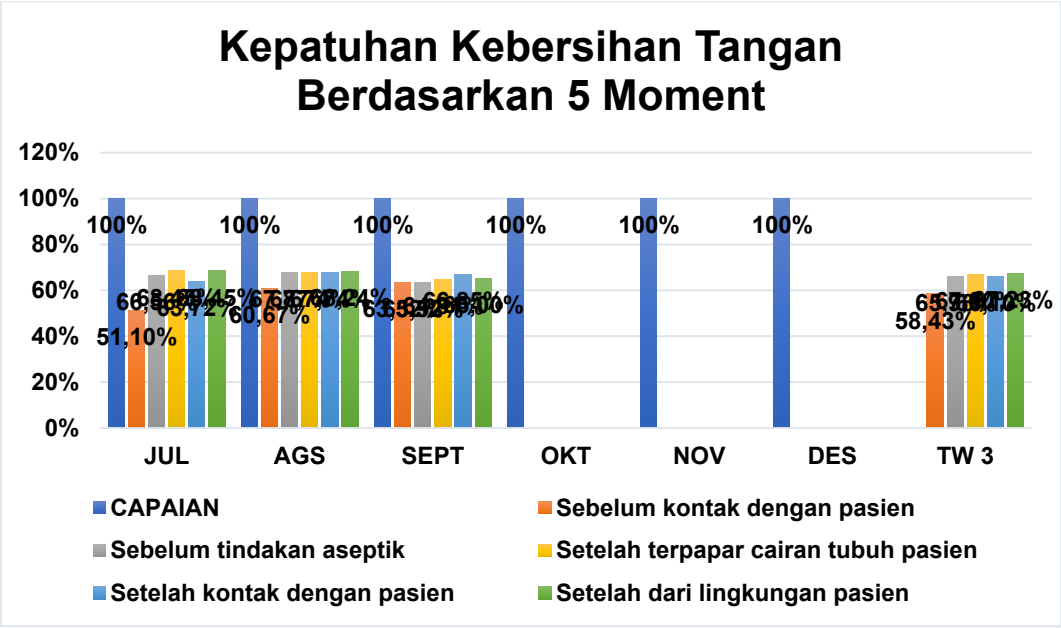
Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.1 diketahui kepatuhan kebersihan tangan pada bulan September 2025 tertinggi berada pada unit Pelayanan (NEO) dengan rerata 87,57%

b) Berdasarkan Profesi
Gambar 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan Berdasarkan Profesi



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan profesi di bulan September 2025 sebesar tertinggi pada profesi Dokter sebesar 85,19% dengan rerata triwulan sebesar 83,58%.

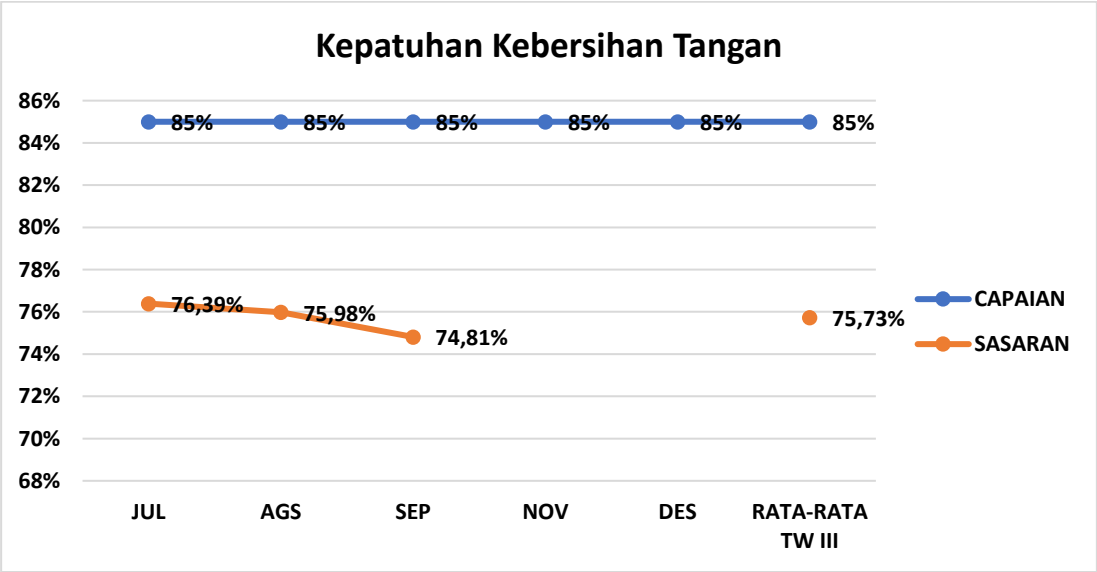
c) Berdasarkan 5 Moment
Gambar 4.1.3.2.1



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.2 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan berdasarkan 5 moment di triwulan III 2025 sebesar

- Sebelum kontak dengan pasien sebesar 58,43%
- Sebelum tindakan aseptik sebesar 65,98%
- Setelah terpapar cairan tubuh pasien sebesar 67%
- Setelah kontak dengan pasien sebesar 66,10%
- Setelah dari lingkungan pasien sebesar 67,23%

Gambar 4.1.3.3 Kepatuhan Kebersihan Tangan



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.3 diketahui bahwa rerata kepatuhan kebersihan tangan di bulan September 2025 sebesar 74,81% dengan rerata triwulan belum mencapai target 85%.

Tabel 4.1.3.2 Kepatuhan Kebersihan Tangan

PROBLEM	Persentase kepatuhan kebersihan tangan bulan September tahun 2025 sebesar 74,81% dengan rerata triwulan sebesar 75,73% dan belum mencapai target $\geq 85\%$.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mencapai kepatuhan minimal 90% dalam 3 bulan dan mempertahankan minimal 85% secara berkelanjutan 2. Harapan Seluruh staf dapat melakukan <i>hand hygiene</i> dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Kurangnya kesadaran akan pentingnya momen 5 cuci tangan WHO b. Ketersediaan handrub yang belum merata c. Supervise dan feedback belum dilakukan rutin d. Ketergantungan pada pengingat eksternal tidak menjadi kebiasaan 4. Tindakan a. Membuat TOR untuk review pelatihan PPI dasar b. Audit harian oleh IPCN dengan feedback mingguan c. Manfaatkan poster, QR-code edukasi vidieo, dan pengingat audio di area kritis d. Berkolaborasi dengan kepala bidang terkait monitoring kepatuhan e. Membuat rencana metode <i>role play</i> HH untuk seluruh staf pada saat melakukan hand over f. Melakukan edukasi kelompok atau individu dengan

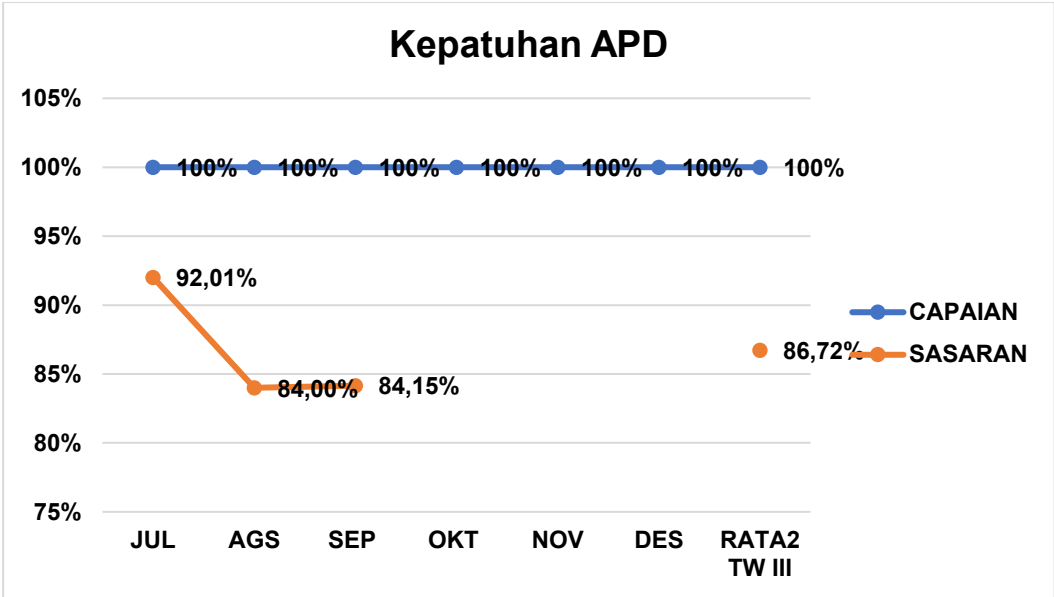
	sasaran pengunjung rumahsakit yang dibuktikan dengan video edukasi.
--	---

Tabel 4.1.3.3 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Re-view ulang SPO kebersihan tangan pada masing-masing unit a. Pelayanan b. Penunjang c. Umum												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin kejadian kebersihan tangan												

- b. Kepatuhan APD

Gambar 4.1.3.4 Kepatuhan APD



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD di bulan September 2025 sebesar 83,55% dengan rerata triwulan sebesar 86,52% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.4 Kepatuhan APD Berdasarkan Unit

INDIKATOR PENILAIAN	BULAN												RATA- RATA	RATA- RATA TW IIII
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3A	88,00%	100,00%	93,10 %	95,15%	100,00%	100,00%	69,23%	77,27%	96,30%				91%	81%
3B	100,00%	90,00%	96,77%	100%	100,00%	100,00%	76,79%	89,74%	61,90%				91%	76%
2A	33,33%	100,00%	98,04%	100%	100,00%	100,00%	97,14%	73,33%	91,67%				88%	87%
2B	100,00%	100%	98,77%	100%	100%	100,00%	81%	71,11%	72%				91%	75%
2D	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				0%	0%
MAT	88,00%	100%	97,22%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%				98%	100%
NEO	88,89%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%				99%	100%
ICU	100,00%	100%	79,17%	45,45%	0%	100,00%	100%	0,00%	100%				69%	67%
IKO	100,00%	100%	0%	0%	100%	0,00%	0%	100,00%	100%				56%	67%
IGD	98,65%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	88%				99%	96%
IRJA	100,00%	89%	98,98%	100%	100%	100,00%	100%	0,00%	0%				76%	33%
CS	27,27%	100%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				14%	0%
As. Center	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				0%	0%
Farmasi	100,00%	100%	0%	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%				89%	100%
Laboratorium	83,33%	56%	52,38%	84,62%	0%	0,00%	0%	100,00%	80%				51%	60%
Radiologi	60,00%	0%	66,67%	100%	100%	0,00%	0%	0,00%	0%				36%	0%
Gizi dan Dapur	83,33%	76%	81,16%	100%	81%	65,22%	100%	66,67%	81%				82%	82%
RM / PDF	0,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				0%	0%
CSSD	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				11%	0%
LAUNDRY	100,00%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0%	0,00%	0%				11,11%	0,00%
B3	87,72%	93,75%	83,33%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	79,49%	0,00%				92,39%	88,89%
LAIN-LAIN	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%

Interpretasi : Pada tabel 4.1.3.4 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD berdasarkan di Unit di bulan September 2025 tertinggi di unit Maternitas dan Neonatologi

Tabel 4.1.3.5 Kepatuhan APD

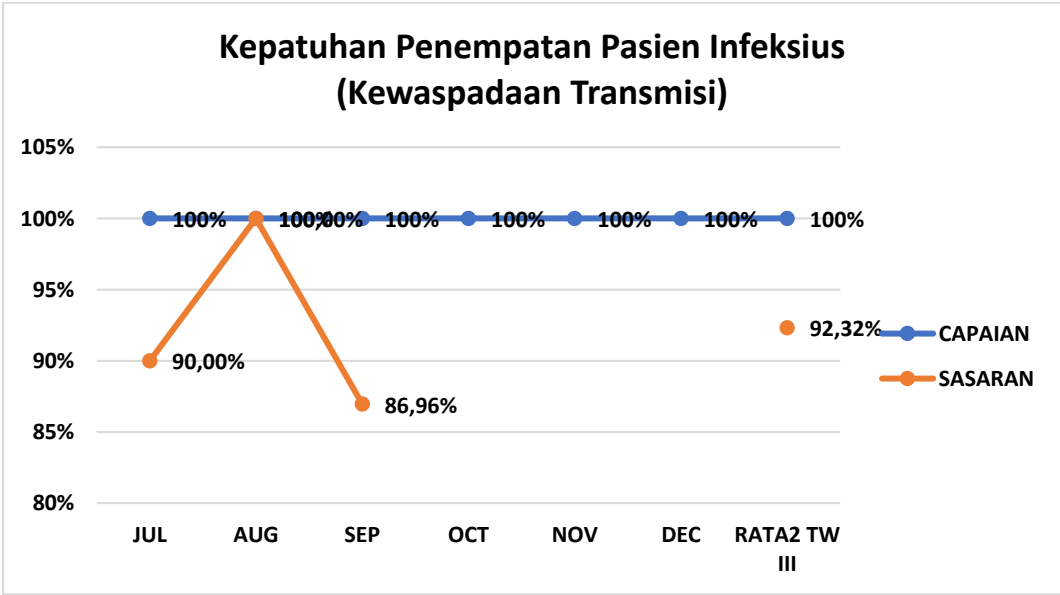
PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	- Rencana: Mempertahankan kepatuhan APD di level 100% secara konsisten dalam 6 bulan ke depan - Harapan Seluruh staf pelayanan medis patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Akar masalah potensial - Ketidaknyaman dalam penggunaan APD (panas, pengap, tidak nyaman dll) - Persepsi bahwa risiko infeksi menurun sehingga kepatuhan bisa longgar - Ketidakteraturan dalam pengawasan langsung di unit - Tindakan - Memberikan pengingat visual di area kerja (poster, stiker, digital signal) - Supervise rutin oleh IPCN/IPCLN - Sistem reward bulanan unit dengan kepatuhan 100% - Simulasi kasus nyata resiko infeksi akibat ketidakpatuhan
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan September tahun 2025 dengan, - Lakukan pemasangan materi edukasi dan pengingat di setiap unit - Lakukan audit dan observasi harian - Berikan umpan balik mingguan dan apresiasi bagi tenaga yang patuh - Lakukan survei kecil mengenai kenyamanan dan persepsi staff tentang APD
STUDY	- Rerata kepatuhan penggunaan APD pada bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 84,15% dengan rerata triwulan 86,67% dan belum mencapai target 100% - Pantau tren kepatuhan : apakah tetap stabil di angka 100% - Analisa hasil audit : apabila ditemukan pelanggaran meskipun tidak dilaporkan - Evaluasi hasil survei kenyamanan dan motivasi tenaga Kesehatan
ACTION	- Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. - Tinjau factor penyebab (missal APD tidak

	tersedia, tidak nyaman dalam penggunaan APD)
	3. Beri feedback pada hasil temuan.
	4. Kolaborasi dengan Karu masing-masing unit untuk monitoring penggunaan APD di unit.
	5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan Karu unit dan SDM untuk penilaian kinerja.
	6. Beri reward pada unit dengan tingkat kepatuhan penggunaan APD 100%

Tabel 4.1.3.6 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Refresh SPO yang tersedia terkait kepatuhan penggunaan APD												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin												

- c. Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius
- Gambar 4.1.3.5 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.5 diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius di bulan September 2025 sebesar 86,96% dengan rerata triwulan sebesar 92,32% dan belum mencapai standart 100%.



Tabel 4.1.3.7 Kepatuhan Penempatan Pasien Infeksius

PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kepatuhan dalam penempatan pasien infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertularnya petugas dalam melakukan perawatan terhadap pasien dengan resiko penulara secara <i>airbone</i> .
PLAN	1. Rencana: Menajga kepatuhan 100% dalam penempatan pasien infeksius sesuai prinsip kewaspadaan transmisi selama 12 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam kepatuhan penempatan pasien infeksius di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah potensial ; a. Ketidaksesuaian pemahaman tenaga jesehatan tentang klasifikasi pasien infeksius b. Sistem triase atau skrining awal tidak optimal c. Ruang isolasi terbatas atau tidak tersedia disaat dibutuhkan 4. Tindakan a. Refresh training tentang identifikasi pasien dengan infeksi menular dan protocol penempatannya b. Standarisasi formuli triase dan SOP pemindahan pasien infeksius c. Evaluasi dan optimasi ketersediaan ruang isolasi d. Audit dan umpan balik harian untuk kasus penempatan pasien baru
DO	Kepatuhan penempatan pasien infeksius belum mencapai 100% dengan melakukan, 1. Lakukan pelatihan ulang kepada perawat IGD, rawat inap dan IPCN 2. Terapkan system checklist pada form masuk pasien terkait status infeksi dan tindak lanjutan 3. Buat system “red flag” di rekam medis pasien dengan infeksi menular 4. Monitoring harian oleh IPCN/IPCLN terhadap semua kasus rawat inap baru
STUDY	1. Rerata kepatuhan penempatan pasien infeksius bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 86,96% dengan rerata triwulan 92,32% dan belum mencapai target 100% 2. Review data audit harian atau mingguan : adakah kasus pasien infeksius tida sesuai dengan tempat 3. Tinjau waktu tunggu antara identifikasi infeksius dan pemindahan pasien

ACTION	1. Review kepada staf terkait kepatuhan penempatan pasien infeksius. 2. Lakukan koordinasi dengan Karu IRNA 2A untuk melakukan re-sosialisasi kembali kepada staff terhadap kepatuhan penempatan pasien infeksius yang dibuktikan dengan terisinya form edukasi terkait tata tertib ruang isolasi 3. Lakukan edukasi kepada keluarga dan pengunjung isolasi untuk tidak keluar masuk ruang isolasi secara bebas, penggunaan APD serta etika batuk yang dibuktikan dengan edukasi kelompok (baik berupa foto atau video) 4. Aktifkan CCTV diarea R. Isolasi dan lakukan kolaborasi dengan satpam RS 5. Beri feedback pada hasil temuan. 6. Beri teguran pada unit yang tidak melakukan penempatan pasien infeksius.
---------------	---

Tabel 4.1.3.8 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

PROBLEM	Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebersihan permukaan di ruang rawat inap yang dapat meningkatkan resiko infeksi nosokomial
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan kebersihan permukaan menjadi $\geq 90\%$ selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Akar masalah a. Petugas CS kurang terlatih atau tidak memahami area kritis b. Ketidakteraturan jadwal atau dokumentasi kebersihan c. Tidak adanya verifikasi atau audit lapangan secara rutin 4. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit. d. Pelatihan ulang petugas CS tentang standart kebersihan permukaan khususnya area sentuh tinggi e. Pembuatan cheklist harian pembersihan permukaan di setiap ruangan (link jobdisk : https://drive.google.com/drive/folders/12xRPis1jwkNrO7



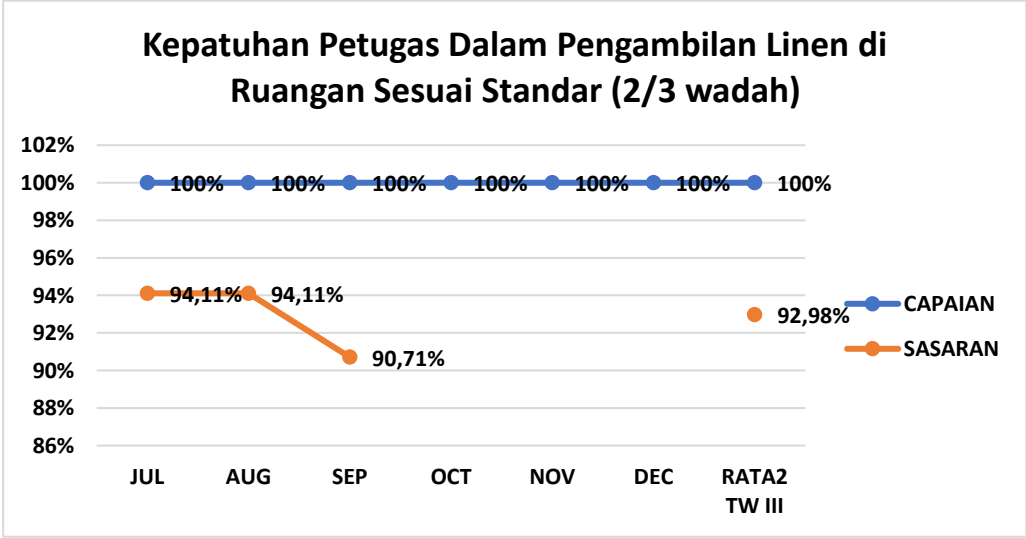
	6kNnKCo73mgiUc51pM?usp=drive_link) 5. Sumber daya - Petugas kebersihan CS yang terlatih - Peralatan pembersih yang memadai - SOP dan panduan visual untuk kebersihan - Peningkatan supervisi lebih sering
DO	Monitoring dan audit kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai target 100% dengan, - Memastikan setiap kamar kosong dibersihkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan - Menggunakan checklist untuk memastikan setiap sudut kamar di bersihkan termasuk tempat tidur, furnitur dan kamar mandi - Melakukan sesi pelatihan ulang terkait pembersihan yang lebih detail, terutama pada area tempat tidur, kamar mandi, nakas dan dinding - Menggunakan panduan visual yang menunjukkan dengan jelas area yang perlu di bersihkan lebih intensif - Melakukan penjadwalan pembersihan tirai/gorden setiap bulan atau lebih sering jika di perlukan - Mensosialisasikan pentingnya kebersihan dan penanganan kebersihan lingkungan kepada semua petugas baik kepada CS dan perawat
STUDY	- Rerata kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap bulan September tahun 2025 yaitu sebesar 90% dengan rerata triwulan sebesar 89,62% dan belum mencapai target 100% - Staff belum cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan dengan beberapa temuan sebagai berikut, - Masih ditemukan beberapa area perawatan yang berdebu, kotor, dan tidak rapi serta kamar mandi bau tidak enak - CS kurang detail dalam pembersihan sehingga saat disupervisi ditemukan area bed dan nakas tampak kotor - Masih ditemukan troli tindakan yang terdapat bercak noda darah - Masih ditemukan tirai/gorden di ruang perawatan yang kotor, berdebu dan di lipat diatas bed - Masih ditemukan linen infeksius yang tergeletak dilantai - Masih ditemukan area kamar pasien atau kamar mandi pasien yang masih kotor dan berbau - Metrik evaluasi yang digunakan, - Audit kebersihan kamar kosong - Audit kebersihan oleh CS - Audit kebersihan troli tindakan diruang rawat inap - Audit kebersihan di ruang IKO - Evaluasi kebersihan tirai/gorden - Penanganan linen infeksius - Evaluasi kebersihan kamar pasien dan kamar mandi
ACTION	- Kolaborasi dengan tim umum terkait pengadaan sumber daya pembersihan lingkungan. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. - Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan

	yang berisiko tinggi
--	----------------------

Tabel 4.1.3.10 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Refresh SPO yang tersedia terkait kepatuhan kebersihan permukaan di rawat inap												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin												

- e. Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah
- Gambar 4.1.3.7 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.7 diketahui bahwa rerata kepatuhan petugas dakan pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah bulan September 2025 sebesar 90,71% dengan rerata triwulan sebsar 92,98% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.11 Kepatuhan Petugas Dalam Pengambilan Linen di Ruangan Sesuai Standart 2/3 Wadah

PROBLEM	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah untuk mencegah



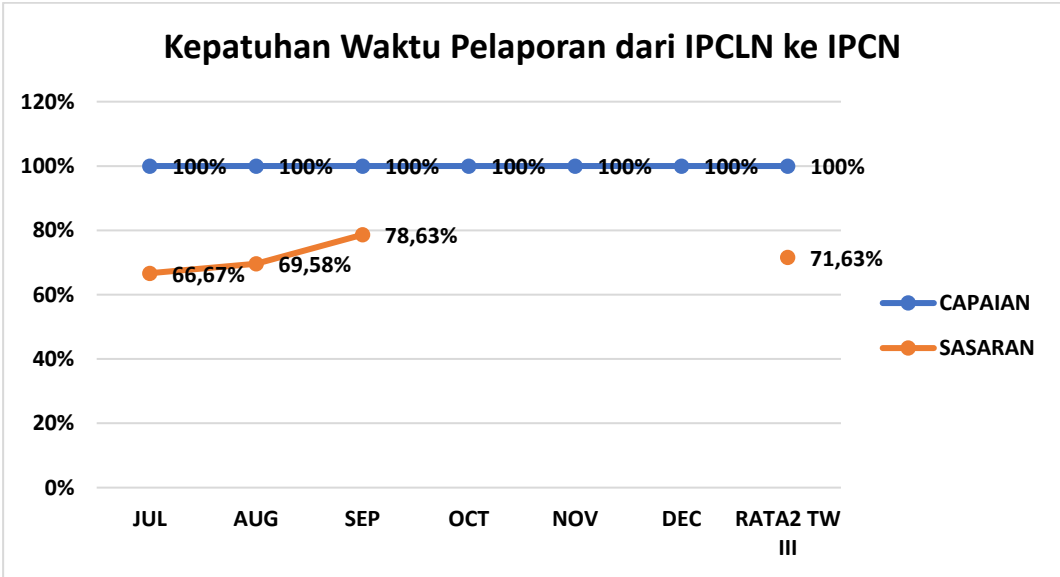
	penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pengambilan linen menjadi 100% sesuai standart selama 3 bulan ke depan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi; a. Petugas belum paham resiko infeksi silang akibat overfilling b. Kurangnya pengawasan atau evaluasi harian c. Tidak tersedia alterbatif wadah bila kapasitas sudah 2/3 penuh d. Tidak ada system peringatan visual di wadah linen 4. Tindakan a. Melakukan audit kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai 2/3 wadah e. Sediakan Cadangan wadah linen untuk kondisi penuh agar petugas tidak terpaksa overfill
DO	Kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah mencapai 100% di bulan berikutnya dengan upaya, 1. Melakukan pelatihan secara singkat kepada petugas kebersihan dan perawat tentang penanganan linen 2. Tempel stiker batas maksimal 2/3 pada semua wadah linen kotor di setiap ruangan 3. Terapkan observasi harian oleh petugas IPCN atau kepala ruangan selama satu minggu pertama 4. Catat Tingkat kepatuhan harian dan lakukan pengingat verbal jika ditemukan pelanggaran
STUDY	1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. 2. Evaluasi data observasi dan bandingkan dengan bulan sebelumnya 3. Lakukan diskusi mingguan dengan petugas terkait tantangan dilapangan 4. Catat perubahan tren kepatuhan dan identifikasi apakah penandaan visual

ACTION	1. Re-sosialisasi kepada staf terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 4. Berikan system reward / sanksi sederhana berbasis performa petugas 5. Lakukan dan kaji ulang kapasitas tempat linen kotor, apabila dibutuhkan penambahan maka unit wajib melakukan SP penambahan tempat linen kotor
--------	---

Tabel 4.1.3.12 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Juli				Agustus				September			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Evaluasi pencapaian pada Triwulan berikutnya												
2	Refresh SPO yang tersedia terkait kepatuhan petugas dalam pengambilan linen di ruangan sesuai standart 2/3 wadah												
3	Supervisi dan monitoring secara rutin												

- f. Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN
- Gambar 4.1.3.8 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN





Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.8 diketahui bahwa rerata kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN bulan September 2025 sebesar 78,63% dengan rerata triwulan sebesar 71,63% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.13 Kepatuhan Waktu Pelaporan dari IPCLN ke IPCN

PROBLEM	Pelaporan dari IPCLN (Petugas Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Unit) ke IPCN (Petugas PPI Rumah Sakit) tidak dilakukan tepat waktu.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penginputan hasil serta temuan di unit terkait surveilans HAI's dan monitoring kewaspadaan isolasi.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan waktu pelaporan dari IPCLN ke IPCN menjadi $\geq 90\%$ dalam 3 bulan 2. Harapan Seluruh IPCLN dan PIC PPI unit melakukan penginputan data surveilans secara real time dan ontime sehingga target kepatuhan dapat tercapai. 3. Penyebab yang diidentifikasi a. Tidak adanya jadwal pelaporan yang terstandart b. Minimnya kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan tepat waktu c. Beban kerja IPCLN yang tinggi tanpa pengganti saat berhalangan d. Tidak adanya system pemantauan atau pengingat pelaporan 4. Tindakan a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh IPCLN dan PIC PPI terhadap pelaporan melalui web PPI https://sites.google.com/view/komite-ppi-rsph-sukorejo b. Berkolaborasi dengan kepala ruang, kepala bidan dan SDM terkait kepatuhan IPCLN dan PIC PPI dalam melakukan kepatuhan penginputan data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi. c. Lakukan evaluasi bulanan terhadap kepatuhan pelaporan tiap unit
DO	Kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans mencapai target 100% dengan upaya, 1. Distribusikan SOP dan jadwal pelaporan kepada seluruh IPCLN 2. Terapkan system pengingat via digital (Wa grub) H-1 dari jadwal pelaporan 3. IPCLN diminta mengisi format laporan harian atau mingguan secara elektronik 4. IPCN mencatat waktu terima laporan dari tiap unit sebagai bahan evaluasi
STUDY	1. Rerata kepatuhan kelengkapan penginputan data surveilans di tahun 2025 di bulan September 2025 sebesar 78,63% dengan rerata triwulan sebesar 71,63% dan belum memenuhi standart 100%

	2. Bandingkan data kepatuhan sebelum dan sesudah intervensi 3. Evaluasi kendala yang muncul selama implementasi 4. Lakukan kuesioner singkat atau FGD dengan IPCLN untuk mendapatkan umpan balik
ACTION	1. Lakukan pelatihan pengisian form PPI by web setiap bulan 2. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kelengkapan data yang telah di isi 3. Lakukan sosialisasi dan edukasi ulang kepada PIC PPI yang belum faha 4. Buat kan SPO pengisian data surveilans dan monitoring kewaspadaan isolasi 5. Lakukan audit per unit dengan identifikasi dan berikan award pada unit dengan tingkat kepatuhan tinggi dalam pelaporan 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Berikan teguran pada IPCLN dan PIC PPI yang tidak patuh dalam melakukan pelaporan

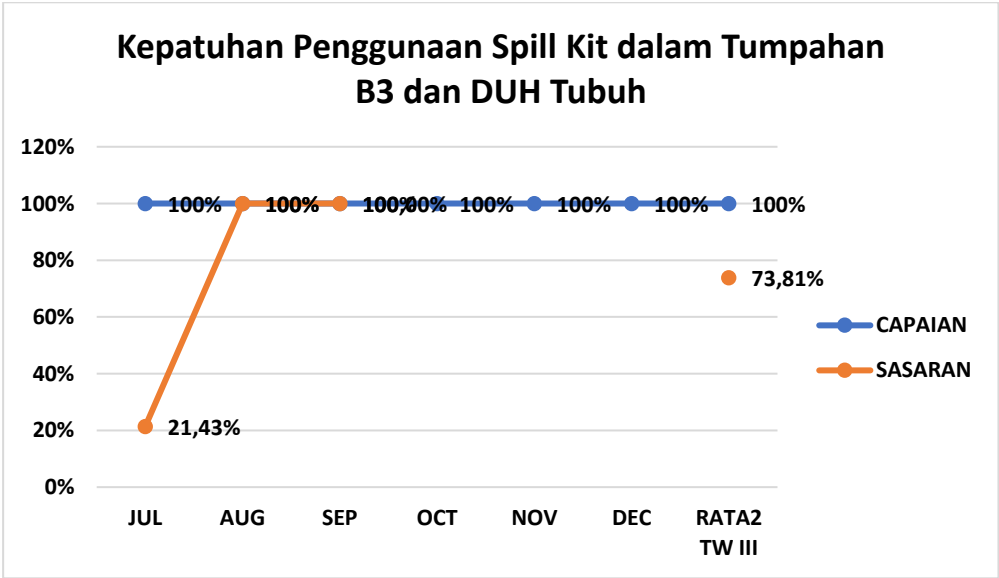
Link pelaporan dan ketepatan IPCLN dalam pelaporan ke IPCN :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jXeIYCCJSp5JRMsbAEduydwwaSi-AOWHlxYA8QYuDqE/edit?usp=sharing>

Tabel 4.1.3.14 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

- g. Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam Tumpahan B3 dan DUH Tubuh
- Gambar 4.1.3.9 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.9 diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan spill kit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan September 2025 sebesar 100% dengan rerata triwulan sebesar 73,81% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.3.15 Kepatuhan Penggunaan Spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH Tubuh

PROBLEM	Petugas tidak menggunakan spill kit secara tepat saat terjadi tumpahan B3 atau darah/urine/cairan tubuh (DUH).
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pelaporan dan penggunaan spillkit dalam menangani tumpahan B3 dan DUH tubuh
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan penggunaan spill kit dalam penanganan tumpahan B3 dan DUH tubuh menjadi ≥ 80% dalam 3 bulan. 2. Penyebab utama a. Spill tidak tersedia dilkoasi yang mudah di akses b. Petugas belum mengetahui prosedur penggunaannya c. Tidak ada pelatihan/praktik secara langsung d. Tidak ada pengawasan atau audit insiden tumpahan 3. Tindakan a. Pastikan keberadaan spill kit diseluruh unit pelayanan beresiko b. Sosialisasi dan pelatihan praktis penggunaan spill kit kepada seluruh petugas c. Tempelkan alur atau poster langkah penggunaan spill kit di area strategis. d. Bentuk tim audit untuk memantau kepatuhan dan tindak lanjut insiden.
DO	1. Distribusikan spill kit ke semua unit yang membutuhkan dan pastikan kelengkapannya 2. Laksanakan pelatihan langsung oleh IPCN/IPCLN (misalnya dengan simulasi tumpahan) 3. Sebarkan media edukasi visual (poster, video singkat). 4. Terapkan form pelaporan jika spill kit digunakan, untuk

	mendokumentasikan insiden.
STUDY	1. Data kepatuhan penggunaan spillkit dalam tumpahan B3 dan DUH tubuh bulan September tahun 2025 sebesar 100% dengan rerata triwulan sebesar 73,81% sehingga belum mencapai standart 100%. 2. Evaluasi jumlah penggunaan spill kit (dari log pelaporan) dibandingkan jumlah insiden. 3. Lakukan survei singkat pemahaman petugas pasca pelatihan. 4. Identifikasi hambatan yang masih dihadapi petugas saat insiden terjadi.
ACTION	1. Beri feedback hasil temuan. 2. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 3. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 4. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 5. Analisis kebutuhan spill kit di unit

Link pelaporan tumpahan dan penggunaan spill kit :

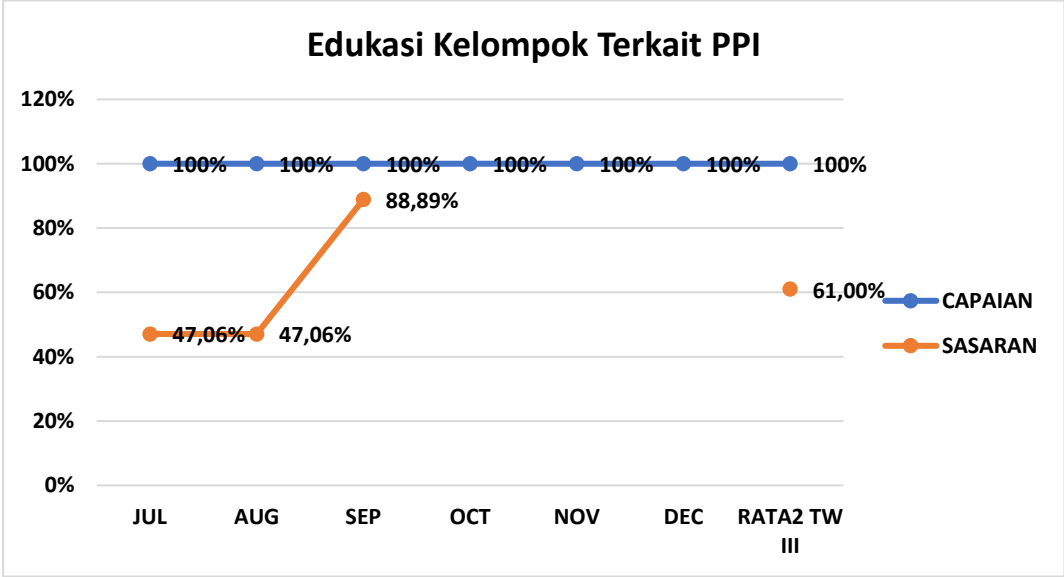
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CV_mGIkTV5vjVPk4D1HuxC4sBZVbR0Ll6EkPMAypTMA/edit?usp=sharing

Tabel 4.1.3.16 Rencana Tindak Lanjut

[illegible]

h. Edukasi Kelompok Terkait PPI

Gambar 4.1.3.10 Edukasi Kelompok terkait PPI



Interpretasi : Pada gambar 4.1.3.10 diketahui bahwa rerata kepatuhan edukasi kelompok terkait PPI bulan September 2025 sebesar 88,89% dengan rerata triwulan sebesar 61% dan belum mencapai target 100%.

Tabel 4.1.4.17 Edukasi Kelompok terkait PPI

No	Nama Unit	Jmlh Edukasi	Jmlh Peserta	Topik	Sasaran
Januari					
1	IRNA 2A	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Hand hygiene	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	ICU	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
		1	5	Hand hygiene	Pasien/pengunjung
8	RM/PDF	1	8	Hand hygiene	Staff
9	IKO	1	3	Pencegahan Infeksi pada pasien post op	Pencegahan Infeksi
Februari					
1	IRNA 2A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung



		1	5	Pemilahan Sampah	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
5	ICU	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
6	IGD	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	6	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Phlebitis	Pasien/pengunjung
7	IRJA	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
8	Maternitas	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan infeksi	Pasien/pengunjung
9	Neonatologi	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
10	RM/PDF	1	8	Cuci tangan	Staff
Maret					
1	IRNA 2A	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
4	IRNA 3B	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika batuk	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	8	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
9	Radiologi	1	6	Pemilahan sampah	Pasien/pengunjung
10	IRJA	1	2	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
April					
1	IRNA 3A	3	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung



2	IRNA 3B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Batuk efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
5	MATERNITAS	1	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
6	NEONATOLOGI	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pemilahan sampah	Pasien/Pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika batuk	Pasien/pengunjung
8	RM	2	8	Cuci tangan	Staff unit
9	IGD	1	8	Cuci tangan	Pasien/pengunjung
		2	8	Etika batuk	Pasien/pengunjung
Mei					
1	IRNA 3A	2	5	Etika Batuk	
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	4	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		2	5	Pencegahan IDO	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
5	IRJA	2	6	Cuci Tangan	Staff
6	Maternitas	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	Perinatologi	1	6	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	6	Pemilahan Sampah	Pasien/Pengunjung
8	ICU	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
9	RM	1	5	Cuci Tangan	Staff
10	IGD	1	7	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	7	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
Juni					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
2	IRNA 3B	3	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Infus Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Eefektif	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung



		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
7	ICU	3	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
8	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
10	RM	1	8	Cuci Tangan	Staff
Juli					
1	IRNA 3A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
		1	5	Infus Plebitis	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
5	Maternitas	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Cuci Tangan	Staff
7	ICU	2	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/Pengunjung
8	RM	1	8	Cuci Tangan	Staff
9	Farmasi	1	5	Cuci Tangan	Staff
Agustus					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		2	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	4	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/Pengunjung
4	IRNA 2B	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		3	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
5	Maternitas	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Pencegahan Infeksi	Pasien/Pengunjung
6	Neonatologi	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
8	ICU	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
September					
1	IRNA 3A	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		1	5	Etika Batuk	Pasien/Pengunjung
		1	5	Plebitis	Pasien/pengunjung
2	IRNA 3B	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung
3	IRNA 2A	2	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
4	IRNA 2B	2	5	Etika Batuk	Pasien/pengunjung



5	Maternitas	1	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
6	Neonatologi	2	6	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
7	IGD	1	5	Cuci Tangan	Pasien/Pengunjung
		1	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
8	ICU	4	5	Cuci Tangan	Pasien/pengunjung
		2	5	Batuk Efektif	Pasien/pengunjung
9	RM/PDF	1	6	Cuci Tangan	Staff

Tabel 4.1.4.18 Edukasi Kelompok terkait PPI

PLAN	1. Masalah Edukasi kelompok terkait PPI belum dilaksanakan secara rutin atau terdokumentasi dengan baik. 2. Tujuan Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan dan dokumentasi edukasi kelompok PPI $\geq 80\%$ dalam 3 bulan 3. Analisa masalah a. Jadwal edukasi tidak tersusun dengan sistematis. b. Petugas tidak patuh dalam melakukan edukasi c. Dokumentasi edukasi sering terlewatkan. d. Kurangnya koordinasi antar unit dengan IPCN/IPCLN. 4. Strategi a. Susun jadwal edukasi mingguan/bulanan di setiap unit. b. Sediakan materi edukasi PPI yang mudah dipahami pasien/keluarga. c. Buat form standar dokumentasi edukasi (manual/digital). d. Tetapkan PIC edukasi di tiap unit pelayanan.
DO	1. Laksanakan pelatihan kepada petugas terkait metode edukasi efektif dan SOP dokumentasi. 2. Distribusikan materi edukasi PPI berupa leaflet, poster, dan video edukatif. 3. Implementasikan sistem pelaporan edukasi harian/pekanan. 4. IPCN/IPCLN melakukan monitoring dan pendampingan awal.
STUDY	1. Evaluasi jumlah edukasi yang berhasil dilaksanakan dan terdokumentasi. 2. Ambil umpan balik dari pasien/keluarga mengenai pemahaman edukasi yang diberikan. 3. Identifikasi unit yang belum mencapai target dan hambatannya
ACTION	1. Beri feedback akan adanya kendala dalam melakukan edukasi kelompok atau individu 2. Koordinasi dengan IPCLN untuk melakukan penjadwalan edukasi kelompok atau individu 3. Monitoring dan evaluasi unit terkait kepatuhan edukasi melalui link edukasi .

[illegible]

4.2 Kesehatan karyawan

Tabel 4.2.1 Data Kesehatan Karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan				Keterangan	Hasil Pemeriksaan
			Fisik	Thorax	HbsAg	HIV		
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	467	206	-	-	-	-	-
4.	April	467	225	-	-	-	Ada penambahan 19 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 242 staff	
5.	Mei	467	285	-	-	-	Ada penambahan 60 staff yang melakukan MCU Total staff yang belum melaksanakan MCU : 182 staff	
6.	Juni	467	285	-	-	-	-	
		10					10 staff penyaji menjalani uji rectal swab pada tanggal 23/06/2025	Hasil Uji Rectal Swab 1) Rikha : Staphylococcus 2) Rima : Salmonella 3) Veni : Salmonella 4) Bina : Pseudomonas 5) Citra : Eschericia Coli 6) Amel : Salmonella 7) Umi : Salmonela 8) Ratri : Klebsiella 9) Ima : Klebsiella 10) Indy : Escherichia Coli
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober							



Interpretasi : Pada tabel 4.2 terkait data kesehatan karyawan tidak ada kegiatan MCU Staff.

Tabel 4.2.1.2 Data Kesehatan Karyawan

PLAN	Meningkatkan kepatuhan staff dalam melakukan kegiatan MCU yang bertujuan untuk skrining utama terhadap rantai infeksi yang terjadi pada tenaga kesehatan
DO	Monitoring kepatuhan staff dalam melakukan MCU karyawan yang dilakukan secara terjadwal
STUDY	Rerata kepatuhan Kesehatan karyawan bulan Maret 0 dikarenakan tidak ada agenda MCU staff dari SDM.
ACTION	1. Koordinasi dengan SDM untuk penjadwalan MCU staff 2. Beri feedback akan adanya temuan hasil dari MCU staff 3. Monitoring dan evaluasi kegiatan MCU staff secara berkesinambungan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kinerja komite PPI pada tahun 2025 didapatkan masih ditemukan banyaknya penilaian yang tidak mencapai target dan masih ditemukan beberapa masalah seperti,

- a. Kepatuhan petugas dalam melakukan *hand hygien*,
- b. Kepatuhan petugas dalam penggunaan APD,
- c. Kepatuhan penyuntikan,
- d. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan,
- e. Kepatuhan penanganan limbah,
- f. Kepatuhan penanganan pembuangan jarum dan benda tajam,
- g. Kepatuhan penanganan tumpahan darah,
- h. Kepatuhan pelayanan makanan,
- i. Kejadian phlebitis dalam 2025,
- j. Ketidakpatuhan petugas dalam melakukan pelaporan dan pengisian di web komite PPI 2025

5.2 Saran

Dari hasil penulisan dan pelaporan triwulan III Komite PPI 2025 diharapkan adanya perbaikan yang dapat dilakukan oleh semua unit dalam proses pelaporan dan penugasan dari Komite PPI terkait,

- a. Pengambilan data di unit oleh IPCLN/PIC PPI Unit terkait audit bundle HAI's, pelaporan HAI's, monitoring dan supervisi, sosialis PPI kepada pasien/keluarga/pengunjung pasien,
- b. Evaluasi dalam berjalannya ICRA Program di unit yang berhubungan dengan Bundle HAI's.

BAB VI PENUTUP

Demikian laporan triwulan III tahun 2025 Komite PPI disusun dan disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025. Segala dukungan dan kerjasama yang diberikan dapat menunjang perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

Pasuruan, 04 Oktober 2025

Mengetahui,
Ketua Komite PPIRS



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

IPCN



Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep., Ns.

Menyetujui,
Plt Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep.



Lampiran :

1. Link Supervisi PPI 2025 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JO8PKQG1PkET_U3IODHmUxZfTRMy1JLkgvpP_PzQRRRA/edit?usp=sharing

2. Link Rekap PPI 2025 :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pf750mUyrg4oJueUUI58h-qF3exSXqQd/edit?usp=sharing&ouid=112068003789464975539&rtpof=true&sd=true>